

1. Ortho/Rhumato

Année	SSP:Diagnostic	Description	Anamnèse	Status	DD	Examen compl	PEC
2013	Épaule douloureuse : Lésion de. La coiffe	Mobilité diminuée depuis 2j, douleurs vive il y a 2 mois lorsqu'il a voulu porter une valise => probable lésion de la coiffe. Mobilité active limitée, passive conservée.	- Caractériser douleur - Mobilité ? - Mécanisme chute ? - Chaleur, rougeur, gonflement ? perte de fct ? - Douleurs mécaniques vs inflammatoire - Main dominante ? - Infection récente ? Fièvre ? (Arthrite septique) - ATCD et TTT - Profession ?	- Inspection - Palpation - Tests de triage - Actif et passif Mobilité passive conservée - Tests spécifiques : - Job Si trauma => vasculaire et neuro	Lésion coiffe des rotateurs Rupture supra-épineux Conflit sous-acromial Capsulite rétractile (Frozen Shoulder) Tendinite calcifiante Tendinite du chef long	Rx - Evtl. US et IRM pour tissu mou	- Diminuer sport, physioth - AINS + glucocort local - Si rupture chez jeune : Chir
2013	Douleurs dos : Fractures ostéoporotiques ?	Femme 62 ans, ménopausée, vient pour des douleurs aiguës au milieu du dos en coup de poignard en soulevant qq branches. L'expert donne une RX du thorax.	- Caractériser douleurs - Rechercher symptômes neuro - Sympt. systémiques (symptômes B) - Troubles sphinctériens	- Inspection/palpation et percussion du rachis - Flexion/ext/inclinaison lat, rotation ? - Ott et Schober ? - Lasègue ? - Examen neuro rapide MI ? TR	Fx ostéoporotique Métastases osseuses Herniation	Rx - Evtl. CT ou IRM	Si Fx stable : Repos selon douleur, AINS, Physio.
2014	Fx col du fémur	= fracture dans la partie prox du fémur	- Caractériser douleur, traumatisme/chute, mécanisme, TC, perte de connaissance, lésion cutanée, se relever lors de la chute, charge possible ou non, autre arthralgie, œdème, rougeur, chaleur, EF - Cinétique - Fx pathologique : Premier épisode, densitométrie récente, ostéoporose, oncologique, complément VitD et Ca - Gériatrie : AVQ, marche seul ou aide	- Jambe raccourcie et en rotation ext. - Inspection/Palpation - Mouv actifs/passifs - Pouls, temps recoloration, sensibilité - Examen articulations à côtés, comparaison controlat.	Luxation hanche Fracture bassin Contusion Lésion genou Arthrose hanche Arthrite hanche	Rx hanche/bassin + genou Densitométrie	Chirurgie +/- prothèse
2014	Spondylarthrite ankylosante	Douleur lombaire chez patient 40 ans => spondylarthrite ankylosante	- Douleur iliosacrée et vertébrale - Présente la nuit - Raideur matinale - Amélioré au mvt - Enthésopathies ? (Achille et tubérosité tibiale) - Arthrite d'autres articulations proches du tronc ? - Iritis ? Uvéite ? - RCUH/Crohn ?	Inspection / Palpation (y.c sacro-iliaques) / Percussion Flexion/Ext / Inclinaison lat / Rotation de la colonne Distance doigts-sol et Schober (aussi colonne cervicale) Marche - Examen mvts hanche Signe de Lasègue + force/sensibilité MI TR : sphincters Signe de Mennell (amboss) FABER Test de Gaenslen Test de Yeoman Régurgitation valve aortique	Ostéoporose Hernie discale Spondylite Arthrite réactive Arthrite psoriasique	Sang : CRP et VS augmenté selon activité. Evtl légère anémie HLA B27 IRM (GOLDSTANDARD) Rx permet de voir des modifs dues à l'inflammation (plus tardive)	- Physique est le plus important : Physio et sport AINS selon besoins - Cortico si crise sévère - Anti-TNF alpha dans cas réservé
2014	Ostéoporose		- FR : tabac, abus d'alcool, ménopause précoce, prise de médoc - Douleurs diffuses du dos - Cyphose et diminution de la taille - Fx col du fémur, radius distal, vertébrale	- Phénomène du sapin - Mesure régulière de la taille	Métastases osseuses Plasmocytome	Sang : FSS, Na, K, Créat, Ca et PO4, VitD, PA et GGT, CRP et VS Densitométrie osseuse : T<-2.5 Rx en 2 plans	- Activité physique - Stop alcool et tabac - Calcium + D3 - Evtl aide à la marche - Post ménopause : Bisphosphonates, Raloxifene, etc..

2015	• Fx fibula	• Cas 38 amboss	• Caractériser la douleur • Hématome, tuméfaction, rougeur, chaleur • Marche possible ? • Première fois ? ATCD d'entorse ? • Tr sensi ? • Fx isolée rare => svt au niveau de la cheville (Weber) • ATTENTION syndrome des loges	• Inspection • Palpation • Status de la cheville • Palper toute la jambe ! • • Hématome et gonflement • Mobilité douloureuse (passif/actif) • Marche ! • • Ne pas oublier pouls + neuro (sensitif)	• Fx tibiale • Fx calcanéum • Entorse	Rx fibula F/P + Rx cheville F/P	• Prévoir contrôle ortho à 1 sem ? • Repos, glace, élévation • Weber A + B (non disloquée) plâtre pdt 6 semaines, béquille, prophylaxie antithrombotique • Autrement chirurgie
2016	• Arthrite septique	• Douleur articulaire genou D depuis 1J => Urgences	• Iatrogène ? • Trauma ? • MST ? • Tableau classique d'articulation enflammée : rougeur, chaleur, tuméfaction, fièvre, frissons • Le plus svt genou et hanche • Lyme : EM ? forêt ? • Reiter : sympt uro, yeux, atcd infection	• Dolor, tumor, rougeur etc... • Status genou : inspection, palpation, signe du glaçon, testing ligaments, ménisques, mouv actifs, passifs, marche	• Goutte, Pseudogoutte • Reiter (yeux, urine, arthrite) • Arthrite de Lyme	• Sang : CRP, VS • Rx en 2 plans • Arthrocentèse	• Hospitalisation • Mettre au repos le membre + AB iv • +prophylaxie thromboembolique +antalgie
2016	• Épicondylite latéral (tennis elbow)	• Douleur au coude chez jeune patient	• Douleur à l'effort et à la pression • Douleur péjorée à la supination, fermeture du poing et extension dorsale du poignet • Caract. douleur, trauma ? atcd de trauma? première fois • Caract infl/mécanique des dlrs • Comme d'hab vu qu'on va donner des AINS important de savoir s'il a l'estomac solide	• Status du coude • Spécifique : douleur latérale à l'extension du coude contre résistance • Dlr à la palpation de l'épicondyle latéral lors de la flexion dorsale du poignet • Inspection, palpation, mouv passifs, (actifs) (flexion/extension/prosupination), force, sensi, réflexe, pouls, tests spécifiques • Comparer les deux côtés	• Bursite (AINS, repos)	• Rx en général ne montre rien	• Interrompre le sport, repos • AINS de courte durée • Physio • (Evtl Cortico injecté)
2016	• Ménisque LCA	• Douleur genou après chute à ski	• Cinétique ? • Mvt de torsion du genou ? • A réussi à se lever dessus ? • a entendu un craquement • Sensation que ça lâche ? • Caract. douleur, hématome ? tuméfaction ? paresthésie, jambe froide ? • 1ere fois ? • ATCD + estomac solide ?	• Status genou complet	• Rupture LCA • Déchirure ménisque • Rupture ligaments collatéraux	• Rx en 2 plans pour exclure fx • IRM	• Attelle velcro • IRM à prévoir et selon résultat rdv chez spécialiste • Antalgie
2016	• Syndrome des loges	• Douleur ++ jambe après tacle au foot chez jeune patient. ASPEC => Syndrome des loges => Urgences (on est dans un hôpital périphérique, dimanche aprèm)	• Douleur progressive et forte, paresthésie, pâleur, pire avec étirement/contraction des muscles • Sympt. Sensitivo-moteur	• Musculature tendue, très douloureuse • Gonflement tissu mou • Pouls conservés jusqu'à tardivement • Inspection, palpation, mvt actifs/passifs, force/sensi/réflexe, pouls • Homans, palpation	• Syndrome tibial ant : • Déficit extension hallux • Tb sensitif au niveau du 1^{er} espace interdigital • TVP • AOMI	• Mesure de la pression invasive intracompartimentale (N<10mmHg) ici 30-40mmHg • Suivre Créat et CK (Rhabdomyolyse)	• Fasciotomie en urgence (dans les 6 premières heures)
2017	• 1. Coiffe des rotateurs • 2. LCA et Ménisque	• CF plus haut					
2017	• Polymyalgia rheumatica		• Sympt. B et dépressives • Douleurs symétriques (surtout nuit) + raideur matinale épaule et hanches, attention développement d'un Horton possible ! Demander si céphalée, trouble vision, douleur à la mastication, dlr cuir chevelu	• Rachis + GALS	• Fibromyalgie • Dermato/polymyosite • Inclusion body myosite (IBM) • PR	• Sang : VS fortement élevée et CRP. Evtl anémie • ANA nég • FR nég • CK normales • Sono : typiquement bursite sous-acromiale ddc.	• Prednisone !

2. Dermato

	Dg	Scénario ECOS	Anamnèse	Status	DD	Examen compl	PEC
2013	Dermohypodermite	Femme 65 ans qui vient pour douleur et rougeur de la jambe depuis 2J avec EF, œdème et ADP fémorale	- Anamnèse : - Localisation ? - Étendue ? - Évolution ? - Douleur ? Chaleur ? Rougeur ? - Œdème ? - FIEVRE ? Frissons ? - Blessures (porte d'entrée) - Immunosuppression ? Diabète ? Hygiène ?	- Inspection, palpation (y.c ganglions !) - Rougeur-chaleur-œdème-douleur - Marquer la lésion pour voir la réponse aux ATB - Regarder entre les orteils pour porte d'entrée	- Eczéma de contact allergique aigu - Thrombophlébite - Acrodermatite chronique atrophiant - Fasciite nécrosante	- Labo : VS, CRP leuco - US si suspicion de thrombose - Frottis bactériologique au niveau de la porte d'entrée probable - Hémocultures si fièvre	- Si visage : - Hospitalisation - Risque de thrombose du sinus caverneux - Mise au repos - Surélévation - Pansement frais et humide - Co-Amox 10j
2013	Prurit généralisé	Homme de 30 ans vient pour prurit généralisé depuis la veille après avoir mangé des crevettes. (Ici le gars propose antihistaminique per os, prednisone per os, crème corticoïdes + pricktest)	- Anamnèse : - Localisation ? - Évolution ? - Caractère migratoire et éphémère ? - Facteur déclenchant/aggravant/soulageant ? - Épisode précédent ? - Symptôme associé ? Douleur ? Voyage ? - Anamnèse de l'entourage - Fièvre ? - Palpitation dyspnée ? - Dysphonie ? Angioœdème ? - Trouble du transit ? N/V ? Diarrhées ? - Perte de connaissance ? - Allergies ? - Nouveaux médicaments - Antécédents ?	- Inspection peau muqueuse cheveux ongle - Ganglions - Palpations avec des gants - Examen Cardio-Pulm - Abdo	- Urticaire (réaction d'hypersensibilité type 1) - Maladie de Lyme - Vasculite urticarienne	- FSS - Tryptase - Sérologie de Lyme - Prick test +/- tests épicutanés - IgE totaux après prick test - Journal des allergies	- Antihistaminique p.os (ex : Zyrtec Loratadine) - Prednisone p.os - Corticoïdes topiques (crème)
2013	Eczéma	Enfant de 10 ans avec lésions dans les plis des coudes	- Anamnèse : - Localisation ? - Évolution ? - Caractère migratoire et éphémère ? - Facteur déclenchant/aggravant/soulageant ? - Épisode précédent ? - Symptôme associé ? Douleur ? Prurit ? - Anamnèse familiale (atopie) - Allergie ? - Asthme, Rhinokonjonctivite ou autres ?	- Cf autres cas, bien regarder dans plis, derrière genou etc... - Xérose cutanée - Chéilite sèche - Dermographisme blanc - Signe de Hertoghe : Perte tier externe des sourcils (aussi dans hypothyroïdie) - Pli de Dennie-Morgan : Doubles plis sous palpébraux augmenté	- Dermatite séborrhéique - Eczéma de contact allergique - Gale	- IgE totaux - Prick tests - Tests épicutanés avec allergènes respiratoires	- Émollients, - Produits non irritants pour hygiène de la peau - Poussées : - Dermocorticoïdes - Immunomodulateurs topiques - Cas graves : - Photothérapie - Corticoïdes systémique courte durée

2014	• Syphilis 2°	• Éruption cutanée chez homme de 40 ans	• 1° • Chancres indolores ? • Lésion génitale, condylome lata (verruques) ? • 2° • Rash maculopapulaire ? Plantaire, palmaire ? • Alopecie en clairière ? • Fièvre ? • Myalgie ? • Fatigue ? • Angine non spécifique ? • Lymphadénopathie généralisée non douloureuse ? • Granulomes mous ? • 3° • Atteinte vasculaire (anévrisme aortique, vx cérébraux) • Atteinte neurologique (douleur déficit neurologique) ? • Pour un rash toujours investiguer MST : HIV syphilis	• Inspection peau muqueuse cheveux ongle • Ganglions • Palpations avec des gants • Inspection génitale IMPORTANT	• HIV • Mononucléose infectieuse gonorrhée • Rash maculopapulaire plantaire et paumes des mains typique syphilis	• Sérologie VDRL TPHA • Test autres MST	• Pénicilline IM • Conseil de prévention : Utiliser des préservatifs
2014	• Scarlatine ?	• Éruption cutanée chez patient de 30 ans	• Anamnèse : • Localisation ? • Évolution ? • Prurit ? • Premier épisode ? • Symptômes associés ? • Infection récente ? • Contage ? • Maux de gorge ? • Langue framboisée ? Squames de mains ? • Lymphadénopathie ? • Fièvre ? Frisson ? • Voyage ? • FR IST ? • N/V ? • Ictère ? • Trouble du transit ? • Vaccins ?	• Inspection • Palpation lymphadénopathie • muqueuse • ORL	• Mononucléose, HIV, CMV, Syphilis, Varicelle, Rougeole, Rubéole, 5ème maladie (HHV6), Parvovirus B19 • Malaria, Dengue • Fièvre jaune • Réaction cutanée à médic	• FSS • Frottis de gorge si érythème • Sérologie MST	• Pénicilline 7 j (si scarlatine) • + ttt symptomatique boire AINS
2015	• Dermate atopique	• Anamnèse puis photo à décrire au dermato puis PEC	• Symptômes cardinaux : Prurit ? • Xérose cutanée ? • Localisation (typique dans les plis) • Anamnèse dermato • Atopie : allergie, asthme souvent association avec rhinoconjonctivite allergique asthme allergique et allergies alimentaires • Anamnèse familiale	• Dermato inspection des plis cou et visage • xérose cutanée • dermographisme blanc • chéilite sèche • double pli sous-palpébraux • perte de la partie latérale des sourcils	• Dermate séborrhéique • Dermate de contact allergique • Gale	• IgE totaux éosinophile • Prick test	• Éviction des facteurs déclenchants, • Émollients, • Utiliser des produits non-irritants • Poussée : • Corticostéroïdes topiques • Immunosuppresseurs topiques • Si sévère : Photothérapie

2015	• Pityriasis versicolor, homme 25 ans, est allé à la piscine	• Photo à décrire ex : multiples macules hypo/hyperpigmentées bien délimitées, rondes sur le thorax/dos	• Apparition de la lésion ? Localisation ? évolution de la lésion ? Épisode précédent ? Trigger ? Facteur aggravant/soulageant ? douleur associée ? Prurit ? • Fièvre ? Contage ? Voyage ? • Est-ce qu'il a mis qqch sur lésions ? • Antécédents • Allergie • 2 formes : hypo ou hyperpigmentée, macule, thorax et dos souvent plus visible après exposition au soleil car ne bronze pas	• Dermato • Inspection • Observation • Palpation	• Vitiligo • Dermatite séborrhéique	• Examen direct au microscope	• Shampooing sulfure de sélénium ou • Antifongique topique 3j
2015	• Acné	• Anamnèse, décrire les images et discuter la prise en charge → comédons, papules, pustules, nodules	• Anamnèse dermato de base : depuis quand, évolution des lésions, localisation, prurit, suintement, douleurs • Qu'est-ce qu'elle a déjà essayé ou mis dessus ? • Anamnèse gynéco (pour PCOS éventuellement)	• Status dermato	• Folliculite	• Diagnostic clinique • Si rebelle au ttt : exclure une hyperandrogénie !	• Dépend du stade ! • Antiseptique (peroxyde de benzoyle), rétinoïdes topiques, acide azélaïque • Si papulopustuleux : ATB topique ou systémique et COC • Si sévère : Isotrétinoïne po, COC
2016	• Stevens-Johnson	• Patient prenant allopurinol depuis 1 mois. Status = description d'image. => URGENCE dermato !!	• 1-3 sem après expo médic : fièvre, flu-like sympt (mal gorge, myalgie, arthralgie) • Puis 1-3 sem après : macules érythémateuses pruritiques, douloureuses souvent visage et tronc. Bulles, vésicules • Localisation • Évolution • Description • Douleurs, prurit ? • Atteinte muqueuse : ulcères oraux/génitaux, conjonctivite, ulcère cornée (photophobie, douleur) • Attention atteinte ophtalmique ! (conjonctivite ulcéreuse, kératite, iritis, uvéite, parfois cécité !) • Infections récentes ? Médicaments pris	• Status dermato : exanthème maculeux sur tronc. Peut devenir vésiculo-bulleux, avec décollement secondaire de l'épiderme. Érosion des muqueuses	• Herpès simplex • Toxidermie médicamenteuse • Pemphigus • Si >30% corps atteint : TEN	• Clinique • (biopsie peau)	• Stop médic causal • Hydrat, soin peau, AB si sepsis • (amboss anglais) • cortico systémique ! Ttt topique symptomatique • (amboss allemand) • Avis dermato, ophtalmo

2016	• Sarcome de Kaposi ?	• Homme 50 ans, • Lésion sur MI => probable sarcome de Kaposi. Décrire la lésion à l'expert + PEC	• Localisation, depuis quand ? évolution, caract. migratoire ? Première fois? • Fièvre, prurit, dlr, dysesthésie, asthénie, perte poids, appétit, sudations • Dyspnée, toux etc. • Anamnèse sexuelle • Voyage • Chercher autres manifs de SIDA	• Décrire les lésions à l'expert : → souvent lésion nodulaire violet-brun ou alors macule pigmentée des fois ou plaques		• Test HIV et autres MST • Virémie • Taux de CD4 • Biopsie peau • Rx thorax • Us abdo → exclure atteinte diffuse	• TTT anti rétroviral si HIV + • Excision chir, cryothérapie, laser
2017	• Psoriasis + eczéma de contact vs médicamenteux		• Anamnèse (comme pour l'eczéma) : • Localisation • Facteurs déclenchants/aggravants/améliorants • Prurit • Desquamation, suintement • Douleurs associées (articulation !! lombalgies !) • Médicaments, utilisations de lotions ou allergènes • Allergies, atcd... • Köbner : apparition lésion après traumatisme • Signe de la bougie : grattage de la lésion fait tomber des squames et en fait sortir d'autres (comme de la cire de bougie, ça n'arrête jamais) • Auspitz : saignement de la lésion lors du grattage de la dernière couche de l'épiderme	• Psoriasis : plaques érythémateuses bien délimitées avec desquamation blanchâtre ; surtout sur faces d'extension des articulations, cuir chevelu, paumes et plantes ; ongles en dés à coudre et taches d'huile ; • Plusieurs formes : en plaque, en goutte, érythrodermie psoriasique (rare et grave)	• Eczéma		• TTT : • Thérapie topique : Vit D, cortico • UVB/PUVA • Thérapie systémique (agents biologiques, cyclosporine A, MTX, rétinoïdes)

3. Pédiatrie

	Dg	Scénario ECOS	Anamnèse	Status	DD	Examen compl	PEC
2013	Ostéomyélite	EF à 39°C + douleur de jambe/genou : Anamnèse a faire + reçoit une carte pour le status (léger œdème fémoral distal, genou un peu rouge et chaud). RX dans la norme. Labo : leucocytose, neutrophilie, VS et CRP augmentées. Pdt toute la consult le papa est anxieux.	- EG, fièvre et frissons - Douleur et gonflement local - Rougeur chaleur - Enfant : métaphyse os long - Adulte : vertèbres	- Palpation douloureuse - Tuméfaction - Membre en position antalgique	- Arthrite septique - Tumeur osseuse	- Labo : - Forte augmentation CRP et VS - Leucocytose avec svt déviation gauche - Hémocs !!! - RX svt dans la norme initialement - IRM pour précoce	- Repos/immob du membre - Hospitaliser et AB iv - Si complications => OP
2013	Bronchiolite à RSV	Nourrisson de 3 mois : dyspnée avec grunting, tirage, marbrure + grosse baisse de l'EG. Période : fin décembre	- Fièvre élevée - Dyspnée, tachypnée, cyanose, grunting, BAN - Toux - Rhinorrhée, écoulement oreilles, se touche les oreilles - Rash - Contage, voyage - Crèche? - Signes de déshydratation: bouche/yeux sec, pipi, yeux enfoncés - Allaitement? Combien de x/j? - Vaccins - Grossesse, accouchement (P, T, PC, adaptation), développement	- Tachypnée - Battement ailes du nez - Cyanose - Expirium prolongé		- Frottis naso-pharyngé pour test rapide - Labo +/- Hémocs - Stix urinaire, culture	- Hosp pour monitorer risque d'apnée - Hydrat - O2 + (B2 mimétique - Evtl adrè - Evtl glucocort)
2013	Convulsion fébrile sur OMA	Survient pdt la montée de la fièvre => svt premier sympt	- Caractériser les convulsions, durées, le plus svt tonico-clonique qui dure 2-3min et cesse spontanément - Typiquement fatigue post-ictale	- Recherche foyer infectieux - Attention méningite	Méningite	- Labo si suspi méningite ou convulsion peu claire - PL obligatoire si moins de 18 mois (on ne peut pas différencier d'une méningite)	
2014	- Ictère du NNé - Cas 37 Amboss - Cas 18 USMLE	Consultation téléphonique	- Âge? ictere du n-né est physiologique entre le 3-8ème jour - pathologique si débute <24h après la naissance persiste >1semaine et >2 semaines chez les prématurés. - Toujours pathologique si augmentation de la bilirubine directe. - L'âge de l'enfant ? Depuis quand il présente un ictere ? Evolution de l'ictère ? Quelles parties du corps sont atteintes ? Est-ce que l'enfant a un abdomen distendu ? Vomissement ? Fréquence des selles ? Couleur ? Présence de sang dans les selles ? Fréquence urinaire ? Couleur urine? Combien de couche mouillée par jour ? Alimentation ? Fréquence ? Force de succion ? Pleurs vifs ? Est ce qu'il est bien éveillé ? Fièvre, infection récente, bouche	- pas d'examen si appel téléphonique - sinon inspection de la peau des muqueuses et sclères et examen abdo	- DD ictere physiologique - ictère sur sepsis - ictère sur incompatibilité ABO (la mère reçoit du anti D normalement) - ictère sur allaitement	- labo : bili transcutanée - FSS - bilirubine directe et indirecte paramètre inflammatoire - Coombs test - groupe sanguin	- Demander à la mère d'amener l'enfant pour l'examiner et faire les examens - sanguins (hémolyse problème de foie)

			sèche, convulsion ? Votre groupe sanguin, celui du papa et du bébé ? Contage ? Autre grossesse ou avortement ? Histoire de la naissance, à combien de semaine, déroulement de la grossesse, complication ? quand le premier caca ? Antécédent de maladie ou chirurgie ? Médicament ? Allergie ? Maladie de sang dans la famille ou du foie (G6PD, sphérocytose, Gilbert, Crygel Nayar) ? • •				
2014	• Fièvre chez enfant de 5 ans	• Consultation téléphonique	• Âge ? T°? Début ? évolution? Convulsion ? Episode précédent ? Dyspnée ? Stridor? Toux? Rhume ? Touche l'oreille ? Otorrhée? Ganglions ? Yeux rouges ? écoulement • Douleur abdominale? N/V? diarrhée ? • RASH? • Douleurs articulaires ? Anomalie de la marche ? Muqueuse sèche ? Pleurs ? Etat général ? Sommeil? Nourriture ? Boit ? Combien ? Combien de pampers mouillé/j ? • Contage ? Vaccins ? • Anamnèse pédiatrie (développement, grossesse, antécédent, anamnèse familiale)	•	• infection urinaire, gastro, méningite, ORL, infection respiratoire, ostéomyélite	• Demander de voir l'enfant pour l'examiner signe de déshydratation ? • recherche du foyer infectieux	• selon diagnostic
2015	• Faux croup	• Vidéo à décrire au pédiatre puis anamnèse avec papa puis PfEC	• infection virale (parainfluenzae i), 4m-5ans, précédé par symptômes URTI. 3S: biphasic Stridor, subglottic Swelling, Seal bark cough. • Q: caractériser plainte (voir plus haut), âge, fièvre, tirage d'oreille, N/V, rash, pleurs/irritabilité, écoulement oeil/oreille, expectoration, dyspnée, tachypnée, have, difficulté à parler, voix rauque, bruit respiratoire, acrocyanose, tirage, urine, sommeil, convulsions, déshydratation (pampers), voyage récent, contage, vaccins, crèche, développement, appétit, dernière visite pédiatre	• -	• Épiglottite • Trachéite bactérienne • CE • Sténose sous-glottique	• XR AP du cou: steeple sign	• Air frais • CS systémiques • Spray d'épinéphrine chaque 1-2h au besoin • Hosp si ne répond pas aux CS après 4h et que stridor persiste au repos • Intubation si sévère • •
2015	• Absence	• Enfant de 7 ans	• Anamnèse habituelle de l'enfant H>F, quand, depuis quand? combien de fois, mouv membre?, PC? automatisme? morsure de langue, perte urine, selles, prodrome, durée, comment il est après? fièvre associée, trauma? vomissement, changement par rapport à d'habitude, fatigue, perte poids ? • Développement? • Comportement à l'école? • Anamnèse périnatale • Vaccin • • (Absence: 5-10 secondes, jusqu'à 100/jours. Pas de convulsion. Regard dans le vide, impression que l'enfant rêve. Mouvements répétés (bouche, tête) PAS de phase postcritique! Trigger: hyperventilation, lumière)	• Status neuro!	• Autre type d'épilepsie • Tumeur cérébrale • Trauma crânien • Hypoglycémie • Convulsions fébriles •	• Anamnèse des parents!! EEG evt. Labo (glycémie, electrolytes, FSS, paramètres inflammatoires, si inflammation hémoc voir PL) Si suspicion de tum: IRM	• Anti épileptique (si absence: ethosuximide) • • Référer au neurologue?
2015	• Cataplexie du NNé = Mort du nourrisson ?	• Bébé trouvé mort dans le berceau : anamnèse avec la mère, status à lire, diagnostic = cataplexie du NNé	•	•	•	•	•

2016	• Méningite/méningo-encéphalite	• EF et léthargie chez enfant de 10ans : Probable méningite/méningoencéphalite : tout sauf status a faire.	• fièvre ? céphalée ? raideur de nuque ? • Status neuro altéré ? • Convulsion? • Photophobie? • N/V? • Rash? • Infection récente ?(Otite, sinusite, immunosuppression) • Notion de trauma ? • perte de sensibilité ? force ? • Contage ? • Vaccin à jour ? • Voyage ?	• Status neuro • Surtout Kernig et Brudzinski • FO	• Tumeur cérébrale • Trauma	• FSS paramètre inflammatoire glycémie électrolytes • 2 paires d'hémocultures • PL CT ou CT d'abord si déficit neuro	• Ceftriaxone acyclovir dexaméthasone dans les 30 min • Si méningocoque ou Haemophilus (si pas vacciné) prophylaxie à tous les contacts étroit : rifampicine ou ceftriaxone 2j
2016	• Acidocétose sur diabète inaugurale	• Acidocétose sur diabète inaugurale enfant de 10ans : vidéo de l'enfant, anamnèse avec la mère et PEC. •	• Événement précipitant • Polyurie, polydipsie, polyphagie ? Perte poids ? Énurésie secondaire ? Fatigue ? • Déshydratation, vomissements, nausées, crampes musculaires dlr abdo, altération EC? • Haleine particulière (comme fruits très mûrs ou dissolvant avec acétone). Respiration de Kussmaul (hyperventile ?) • • Développement • Vaccins	• ABC, Status neuro TA • Abdo	• Infections (gastro, infection urinaire) • Intoxication (ASS)	• FSS, glycémie, Elytes, Créat, urée, corps cétoniques, gazométrie, urine (corps cétoniques, glucose) evt culture.	• Hosp • HYDRATATION avec solution isotonique 0,9 NaCl 1L pendant 1ère heure, recompensation élytes, faire baisser le glucose lentement
2017	• Énurésie 1° • Cf cas USMLE n°41	• Première consultation pour énurésie primaire (mais sec pdt 2 mois attention !!) chez enfant de 7 ans	• Demander fréquence, chronologie (depuis toujours ? Toutes les nuits ? La journée aussi incontinence ?) Quantité d'urine, déjà essayé des méthodes (médics, interventions, alarmes ?) • Comment le problème affecte l'enfant/parents/vie de famille ? • Comment vous réagissez ? Gronder ? Féliciter si sec ? • Facteurs aggravants/soulageant ? Stress modifie le symptôme ? • Mange et boit le soir ? • Anamnèse urinaire (dysurie, urgence urinaire, couleur, hématurie) • Anamnèse abdo : constipation, douleur ventre ? • Sommeil : ronfle ? Se réveille souvent ? • Changements d'environnement ? • -stress à l'école, à la maison, amis ? • -histoire familiale d'énurésie ? • - atcd généraux (OP/maladies, naissance, poids, taille, développement, particulièrement ATCD neuro) • Médics, allergies • Vaccins	• Sûrement cas téléphonique ou uniquement en présence du parent, normalement pas de status	• Énurésie monosymptomatique primaire (dx d'exclusion, peut être familial) • Infection urinaire • Énurésie secondaire, si le patient à été sec pendant >6mois, (dû à trauma, divorce parents, etc) • Constipation • Apnée du sommeil • Troubles fonctionnels de la vessie	• Status génital, • Stix • Sédiment et culture d'urines • Éventuellement évoquer US rénal, Créat, etc...	• Dire qu'on veut examiner l'enfant tout d'abord, options de traitement selon ce qu'on trouve à l'examen... si c'est énurésie primaire monosymptomatique : • Alarmes qui sonnent quand la culotte est mouillée • Médics en 2ème intention : desmopressine • Pas besoin de traiter s'il a < 6 ans
2017	• Ictère du NNé	• Cf plus haut	•	•	•	•	•
2017	• Papa veut qu'on lui explique les vaccins pour son bb de 2 mois sans être réticents	• Empathie et non jugement, explorer les croyances et les volontés des parents • Voir ce que connaît déjà le papa, compléter ses connaissances • Voir ce qu'il veut savoir • Expliquer les bénéfices : protection de groupe, prévenir les conséquences des maladies, garder les maladies éradiquées éradiquées, c'est plus sûr de les faire que les risques de les avoir. Diminue le risque de la mort					

		subite du nourrisson. • Expliquer les risques : EF, rash, rougeur locales, réaction allergique, les autres sont très rares, et dure que quelques jours • Contre-indications : si EF, immunocompromis éviter les vaccins vivants, éviter si réaction anaphylactique précédente lors d'un vaccin, si allergie aux œufs, • Vaccination SUISSE : 2-4-6 mois à Diphtérie, tétanos, coqueluche, Hib, poliomyélite, +/- HBV • 12 mois à ROR • 15-24 mois à diphtérie, tétanos, coqueluche, Hib, poliomyélite, ROR, +/- HBV • 11-14 ans à HPV chez fille et garçon • • Donner documents écrits • Proposer un délai de réflexion •
--	--	---

4. Psychiatrie

	Dg	Scénario ECOS	Anamnèse	Status	DD	Examen compl	PEC
2013	• Schizophrénie	• Menuisier de 19 ans, s'est coupé la main et entend des voix (2eme épisode psychotique chez un patient déjà connu pour ca. => Schizophrénie)	• symptômes positifs : hallucination auditive ? olfactive ? sensitive ? visuelle? intermittent constant ? description? bienveillante malveillante ? est ce que vous avez l'impression d'entendre la pensée des gens (bizarre) ? vous avez l'impression d'être hors de votre corps ? Désillusion? • symptômes négatifs : apathie? diminution de la concentration ? dépression ? tristesse ? anhédonie ? suicide ? trouble du sommeil ? • Autres: risque d'hétéro ou auto agressivité, anamnèse familiale, épisode similaire, ttt, drogue, OH, tabac, support social, home	• niveau de conscience orientation (temps personne lieu) apparence, affect, langage (quantité vitesse contenu) pensée (sentiment d'irréalité de dépersonnalisation)perception(hallucination, illusion) délire, attention, mémoire (capacité d'apprentissage)	• schizophrénie • trouble de la personnalité • schizoïde • schizotypique • trouble schizo-affectif • dépression avec élément psychotique	• TSH • toxicologie •	• hospitalisation mise en place d'un ttt antipsychotique 2ème génération (év. haldol en aigu)
2013	• Dépression du postpartum	•	• Distinguer du Blues du PP () • Commence dans les 4 semaines suivant l'accouchement, dure 2-6 mois. Symptomatologie sévère: extrême désintérêt de l'enfant, suicide et idéation infanticide. Psychose rare (0.2%)	•	•	•	• Psychothérapie • SSRI court terme (d'après études ok même si allaite) • Si très sévère ou psychose: ECT
2014	• Dépression chez la personne âgée	•	• Depuis quand, état dépressif, anhédonie, baisse de la concentration, perte de mémoire, fatigue, confusion/démence, facteur déclenchant, poids changeant, appétit, sommeil, anxiété, trouble du comportement, idée suicidaire, alcoolisme, accentuation trouble de la personnalité • Symptômes neuro • Relations, environnement, troubles métaboliques • Hallucinations?, Délire, anxiété, épisode maniaque avant? • Chez personne âgée : surtout symptômes somatiques ! • Médic, tabac, alcool, atcd, drogues • Eval gériatrique: AVQ, chute, incontinence etc •	• Examen thyroïde • Status psy (orientation, mémoire, attention)	• Hypothyroïdie • Déf. en B12 • Démence	• Imagerie cérébrale • Vitamine b12, électrolytes, bilan calorique, albumine, TSH, •	•
2014	• Trouble du sommeil	• Stress et mauvaise hygiène	• cf cas 16 Amboss	•	•	•	•
2014	• Trouble anxieux	•	• Depuis quand? • Progression • Trigger? • Bouche sèche, sudation, tremblement, palpitation? Dyspnée, drs, N/V, hot flushes • Conséquence sur sa vie personnelle, familiale, professionnelle • Attaque de panique? • Phobie • Tout le temps stressé pour tout, personne soucieuse? • TOC: pensées intrusives, routines/rites qu'il se sent obligé de suivre? • Humeur? • Hallucinations? • Hyperthyroïdie: tremor, perte poids, augm appétit, oligo/aménorrhée/dysfonction érectile/gynécomastie, intol	• Cardio • Pulm • Thyroïde • Psy: orientation, mémoire, décrire son humeur	• Tr anxieux généralisé • • Attaque panique • • Phobies • • PTSD • • Angor • FA • Hyperthyroïdisme • Sevrage OH •	• Labo: TSH • ECG?	• Psychothérapie TCC • • Relaxation • • Bb bloqueur • SSRI

			- chaud, diarrhées, fatigue, palpitation. • Sommeil? (cauchemar, flashback) • Suicide • Support social • Enfance traumatisme? • Comment vous décrive les autres? qqun d'inquiet? • ATCD psy (famille aussi) • OH, tabac, drogues •				
2015	• Burn out/dépression	• Anamnèse et PEC	•	•	•	•	•
2015	• Boulimie chez fille	• femme 24 ans, ne veut pas voir le médecin, vient sur ordre de sa mère, déni total de son problème	• Si patiente très fâchée, lui dire qu'on comprend qu'elle puisse être en colère, mais qu'on est là pour l'aider et que si elle est d'accord on va prendre un moment pour discuter avec elle. Rappeler le caractère confidentiel de l'entretien. • Qui lui a dire de venir? • Demander pourquoi sa mère veut qu'elle nous voit? • Qu'est-ce qui l'inquiète? Si elle aborde les TCA, demander qu'est-ce qu'elle connaît de ça? Est-ce qu'elle connaît qqun avec un trouble comme ça? Comment elle se comporte avec la nourriture? Qu'est-ce qu'elle mange dans un jour type? • Sinon entrer en contact via les conséquences qu'elle pourrait avoir de la boulimie (dents...) • • Qu'est-ce qu'elle pense de son comportement? Est-ce qu'elle le trouve normal? • Comment elle le vit au quotidien? • Impact sur sa vie? • Qu'est-ce qu'elle ressent? • Emotions • Humeur • Anxiété • Suicide (auto-mutilation?) • Environnement socio-professionnel-familial • Essayer d'avoir des infos sur combien de fois elle a crise de boulimie, depuis quand, si y a comportements compensatoires (vomissements, laxatifs, sport, jeûn, diurétiques), un trigger, sentiment de perte de contrôle • Comment elle se décrirait physiquement? • • Anamnèse du poids • Conséquence sur la santé: aménorrhée, pb dentaire, brûlure estomac, tuméfaction glandes salivaires, peau sèche/ongles cassants • • Pas oublier trucs de base: AS, ATCD, OP, hosp, allergie, médic, AF (atcd psy, de tr alimentaire) • OH, tabac, drogue	•	• Anorexie • Hyperphagie	• FSS, électrolytes, créat, ASAT/ALAT • • ECG	• Psychothérapie • SSRI
2015	• Épisode maniaque • cf cas RESCOS 2018	• Anamnèse status et PEC (probable tb bipolaire de type 1)	•	•	•	•	•

2016	• Pédopsy	• discussion avec mère d'un enfant de 8 ans ayant des problèmes d'apprentissage à l'école.	• Préciser quels problèmes: dyslexie, dysorthographe, dyscalculie, déficit d'attention, hyperactivité • En quelle classe? • Difficulté en quelles branches... • Langue maternelle, autres langues • Depuis quand? • Facteur déclencheur? • • Comportement: à l'école (que dit sa maîtresse), à la maison, avec ses copains, Frères, soeurs • Activités extra-scolaires • Comment ça affecte les parents/l'enfant. • • AS: infection récente, dyspnée, toux, fatigue, poids, appétit, dlr abdo, N/V, diarrhées/constipation • Énurésie? Céphalées, tr visuel, auditif? sensi, force, absence? convulsions, stéréotypie, fuit le contact • Humeur • Anamnèse grossesse (OH), périnatale: PREMA?? • Développement: marche, langage • ATCD, AF • Vaccin	• Neuro	• THADA • syndrome OH foetal • prématurité • psy • autisme • tr. conduite	• Eval neuropsych • EEG	• selon cause • prise en charge MDT • • Ritaline (>6y..).
2016	• demande prescription Xanax	• demande une prescription de Xanax à une permanence médicale => anamnèse psy à effectuer (Pas un entretien motivationnel)	• Pourquoi elle veut ça? Qu'est-ce que ça lui apporte? Est-ce qu'elle en a déjà pris? Pour quelles raisons? Qu'est-ce qu'elle connaît de ça? Est-ce qu'elle est d'accord qu'on lui explique les ES potentiel etc. • Après anamnèse psy de base: humeur, anxiété, hallucination, délire, suicide, • Si anxiété, exclure qqch de somatique (hyperthyroïdie...) • Anamnèse personnelle, familiale, sociale, professionnelle • ATCD psy personnels et familiaux • OH, tabac, drogues •	• Status psy: • Orientation mémoire	•	•	•
2016	• Psychose post-partum	• patiente ayant accouché il y a 2j (hôpital périph et il est 3h du matin)	• Comment s'est passé la grossesse? l'accouchement? la suite? • Comment va l'enfant? Relation avec lui. • Comment elle se sent? • Humeur • Anxiété • Hallucinations, délire • Risque suicide, infanticide • ATCD psy personnel, familiaux • Anamnèse gyn: autres grossesses? comment ça s'est passé? • Situation sociale, familiale, personnelle... • OH, tabac, drogue • • Typique: délire mystique, idée de substitution ou subtilisation du bébé, déni de la maternité, du lien de paternité avec le conjoint, conviction que l'enfant va mourir/qu'il est malade, dépersonnalisation, déréalisation, angoisse majeure, labilité émotionnelle, incapacité de s'occuper du bébé et d'avoir une relation affective avec lui • Risque suicidaire et d'infanticide +++++	• Status psy: orientation, mémoire...	• ECA? • Schizophrénie • Tr schizo affectif	•	• Tel. psy de liaison • Hosp unité mère bébé • (les séparer avec visites) • • ou hosp mère en psy et bébé en péd. • • Ttt antipsychotique
2017	• Palpitation	• jeune femme avec cause cardiaque exclue => cause anxiogène	• Tout au long de l'entretien, si patient.e a l'air anxieux.se : encourager à parler de son ressenti, rassurer en disant que n'importe qui se serait senti comme ça dans cette situation et dire qu'on prend au sérieux la plainte, représentation de	• Status psy, points du RESCOS (pertinence discutable) : • Orientation (temps, lieu, espace) • Mémoire (liste mots) • Demander de décrire l'humeur	• DD: anxiété, trouble anxieux, trouble panique ?	• ?	• A discuter avec la patiente : Suivi chez généraliste, • arrêt de travail (selon

			la maladie • -bien décrire le symptôme, (chronologie, trigger(situation,etc), trauma dans le passé?, rythme des palpit, facteurs aggravants/soulageants, symptômes associés (maaises?hyperventilation, bouche sèche, transpi, fourmillements, tremblements)) • -impact sur le quotidien,famille amis job ? • -rechercher spécifiquement : appétit, sommeil, fatigue, concentration, irritabilité, tension musculaire, l'impression d'être à bout. • -dépression? • -Demander quelles investigations ont été faites, ce qu'elle a compris et ce qu'elle pense de la conclusion • - rapide anamnèse cardiovasc (?) et systémique • -Symptômes B + anamnèse personnelle (maladies&OP&hospit(aussi psy!!)) + drogues/alcool/sexe/tabac/allergies + traitements + anamnèse familiale (aussi psy!) • -Travail • -Lien avec famille&amis • -Idées noires • -Ressources (est-ce que vous avez quelqu'un à qui en parler?qui pourrait vous aider?)				situation) • psychothérapie • , évoquer Lorazepam en cas de crise (en R jusqu'au prochain RDV), et pour le long terme: antidépresseurs (citalopram)
2017	• Trouble du sommeil	•	•	•	•	•	•
2017	• Décompensation psychotique	• Jeune qui entend des voix qui le dévalorise	•	•	•	•	•

5. EM-Bilan-Suivi

	Dg	Scénario ECOS	Anamnèse	Status	DD	Examen compl	PEC
2013	Motivationnel OH	Le patient ne voit pas le pb	Combien, quel type d'OH, quand, depuis combien de temps, question CAGE, anamnèse sociale, travail, home, tabac, OH, conduite, dépression, risques!!!	-Entrer dans le monde du patient: créer un lien, explorer son vécu. -Focaliser autour du sujet de discussion: aborder le sujet, situer le contexte, demander la permission, explorer la situation -Évoquer le changement: pk changer, projeter le patient dans l'idée de changer, informer, conseiller -Prévoir la suite: comment changer, négocier les prochaines étapes, proposer une suite! Proposer une information écrite	•	•	-Suivi rapproché -Disponibilité -Alcoolique anonyme
2013	- Motivationnel médicamenteux - Retour a domicile post BPCO	migrante espagnole souffrant de diabète et qui a mal aux 2 jambes à cause sa PNP car ne prend pas ses médocs + évaluer tous les facteurs socio-culturels	•	•	•	•	
2014	Trouble compliance	suivi de la maladie coronarienne	- Caractériser la maladie - Quels ttt, si compliance ok, effets secondaires supportés - Etat actuel, anamnèse cardiaque - FRCV, vasculopathie, troubles érectiles, AOMI, perte d'audition (aspirine), saignements • •	•	•	•	- Vérifier les médicaments - TTT habituel : - Antiagrégation plaquettaire (si stent double) : aspirine ou clopidogrel • - FRCV : statine, bêtabloquants, IEC, nitroglycérine, anticoagulation orale
2014	Trouble compliance	suivi insuffisance cardiaque	•	•	•	•	•
2016	Refus CMS	Patiente démente avec mal perforant refusant le CMS pour soin à domicile	- Est-ce qu'elle serait d'accord qu'on discute un moment de son pied? - Qu'est-ce qu'elle a compris? Pourquoi elle ne veut pas le CMS, avantage qu'elle voit du CMS? - Si pas sa CD, demander si qqun est désigné comme représentant thérapeutique	•	•	•	•
2016	Attitude réa en pré-OP	Ne souhaite pas être réanimé (anamnèse uniquement)	Capacité de discernement?	1. Quels sont les choix possibles ? 2. Quels sont les éléments essentiels que le patient doit avoir compris ? 3. Le patient a-t-il compris ces éléments essentiels ? Sinon, puis-je y remédier ? 4. Est-il capable de raisonner avec ces éléments ? Sinon, puis-je y remédier ? 5. Les applique-t-il à sa propre situation ? Sinon, puis-je l'aider ? 6. Exprime-t-il un choix ? Sinon, ne veut-il pas ou ne peut-il pas ? 7. Une pathologie métabolique, neurologique ou psychiatrique est-elle présente et susceptible d'affecter sa capacité de discernement ? 8. Si oui, traiter les causes réversibles et envisager une évaluation psychiatrique	•	•	•
2016	Annonce de changement ttt (mauvaise nouvelle?) + capacité de discernement	Annoncer à un patient diabétique que les ADO ne fonctionnent plus et qu'il faut passer à l'insuline + discuter des FR du diabète +	•	•	•	•	•

		évaluer sa capacité de discernement.					
2017	• sortie d'hospitalisation	• revoir médocs, suite de Physio	•	•	•	•	•
2017	• sortie d'hospitalisation	• entretien de sortie de BPCO	• Bien montrer comment utiliser les sprays	•	•	•	•

6. Gériatrie

	Dg	Scénario ECOS	Anamnèse	Status	DD	Examen compl	PEC
2013	• Démence • Cf cas 17 Amboss	• Homme 75 ans, ne reconnaît plus sa femme de 80 ans, perte de mémoire progressive, complètement dépendant dans AVQ (envisager EMS ?)	• Depuis combien de temps • Ev. Précipitant • Progression • Première fois ? • Trauma tête • Céphalées • Fatigue • Incontinence • Sommeil • Appétit • Pb marche • Chute • Se perdre ? • Intolérance froid, cheveux secs, constipé • Hallucinations • Faiblesse, paresthésie • AVQ • Dépression : anhédonie, tristesse, coupable, perte d'énergie, tr concentration, psychomoteur, suicide	• Palpation thyroïde • Neuro : NC, force, sensi, ROT, marche, doigt-nez, Babinski, Romberg • Orientation, répéter 3 mots, MONDE, répéter phrase, dénommer objets • Répéter les 3 mots	• Alzheimer • Dépression • Hydrocéphalie à P normale • Démence vasculaire • Hypothyroïdisme • Carence en B12	• Labo : FSS, TSH, B12, électrolytes	• Proposer aide (CMS) • TTT causes réversibles de démence
2014	• Alzheimer débutant	• Tb mémoire/démence => Alzheimer débutant	•	•	•	•	•
2015	• Anamnèse détaillée	• Personne âgée qui chute et qui se plaint un peu de tout (seulement anamnèse et demander status qu'on va lire)	•	•	•	•	•
2016	• ECA	• Patient 70-80 ans hospitalisé pour OP hanche il y 3J. Fils présent (Anamnèse, Status à dire à haute voix et expert dit les résultats + PEC) •	• Anamnèse probablement impossible avec la patiente donc hétéro anamnèse avec le fils: • Qu'est-ce qui se passe? Depuis quand? Constant/intermittent? Progression? Trigger? Se plaint de douleurs, de qqch? • Qu'est-ce qu'elle a eu comme op, quand, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? • Changement de médics?	• Cardio-pulm • Abdo • Neuro: • TR	• Sur globe vésical • Sur sepsis • Sur hyponatrémie • Sur AIT, AVC • Sur fécalome	• Labo: FSS, Na, K créat, CRP, ASAT, ALAT • US abdo: globe	• Selon cause • Sondage vésical si globe...
2017	• Tb mémoire débutante - vieille dame	•	•	•	•	•	•

7. Neurologie

	Dg	Scénario ECOS	Anamnèse	Status	DD	Examen compl	PEC
2013	Convulsions	femme de 22 ans, PC avec convulsion en boîtes, pas de substances illicites, que 3 verres d'OH, pas d'ATCD de convulsion ou épilepsie. Pas de notion de TCC ? Il faut faire un exa neuro (et au milieu l'expert t'arrête pour te dire que le reste est dans la norme). PEC le gars était pas trop sur.		Neuro! (+/- cardiopulm)	- Hypoglycémie - Masse - Sevrage - Méningite	- prise de sang - imagerie - EEG 24-48h	- en attendant pas - conduire, nager, bain, travail en hauteur - antépépileptiques - si tumeur ou 2 crises en 24h - consulte neuro
2013	HSD	- petit vieux amené par sa fille pour trouble de la marche, céphalée nouvelle + sous sintrom. Examen neurologique à effectuer. Puis CT cérébral à la recherche d'une HSD ?					
2013	Céphalée + PC	- Thrombose veineuse? - Pas très clair..					
2014	- Névrite optique - Plainte: tr. vue	suspicion de SEP inaugurale?	- Un oeil, les deux? Diplopie, trouble, mouches volantes, flash lumineux, douleur, rougeur, prurit, photophobie, visions des couleurs altérée. - Céphalées? tr sensi/force, marche, vertiges, dysfonction autonome (vessie, intestin) - Depuis quand? - Constant/intermittent - Progression - Première fois? - Trauma? - N,V, Fièvre... - Anamn. système	Neuro complet: - Tr mémoire, concentration - Paralysie NC - Perte des réflexes cutanés abdo - Spasticité, hyperréflexie, Babinski + - Tr sensi - Tremor d'intention - Nystagmus Ophthalmo complet: - FO - Champs (quadrant, périph) - Acuité - Vision couleur - Frenzel - Fixation, poursuite, saccade, convergence, mouv., pupilles		- IRM (PL)	- Pour exacerbations: Glucocortico hautes doses
2014	AVC	Hémiplégie MSD	Depuis quand? Evolution, comment se sentait avant faiblesse, tr sensi, PC, convulsions, fièvre, N/V, DRS, palpitations, pb pour parler/avalier, tr visuels, incontinence urine/selles, chute? trauma	- Neuro complet - Cardio-pulm: ausculter les carotides!	AIT, HSA, hématome sous dural, masse	- Labo - CT sans contraste - US doppler carotides - ECG - ETO	Ischémique: - Thrombolyse - Thrombectomie Hémorragique: - Réverser coag - Craniotomie, évacuation du caillot

2015	Hernie discale	Pas de perte sphinctérienne	- décrire la plainte (ne pas oublier irradiation!) - trauma - incontinence uro-fécale - trouble sensitivo-moteur	- Examen dos - Neuro - Lasègue - TR		- imagerie si : - queue de cheval >6 semaines - trauma - déficits neuro imp ou en pèjoration	- physio - antalgie +/- arrêt de travail - Rdv à 1 semaine (revenir avant si apparition de trouble neuro-sensitif ou sphinctérien)
2015	- Paralysie faciale périph https://www.revmed.ch/RMS/2009/RMS-188/Paralysie-faciale-diagnostic-et-prise-en-charge-par-le-medecin-de-premier-recours	homme 50 ans jardinier	Erythème migrant? - Arthralgie migratoire? - sympt grippaux - sympt cardio - tr vue, tr audition? - Ou exactement? Depuis quand? Progression? Apparition abrupte? Première fois? - Sympt associé: paresthésies, sécheresse buccale/yeux, hypoguesie, audition? tr force/sensibilité ailleurs, vertiges, céphalées..... - Travail? hobbies? en forêt? - Anamnèse sexuelle pour VIH...	- Exa neuro complet (ORL)	Paralysie de Bell (lien avec HSV) (unilat, installation rapide <3j, status neuro et orl normal, pas d'EF, pas de signes méningés) Lyme - Guillain-barré (=miller fisher) (visions double, ophthalmoplégie, souvent atteinte bilat) - myasthénie grave - Zona otique - AVC - Méningite - HIV, syphilis	- Sérologie Lyme, Syphi - Attention si installation lente: IRM pour susp tumeur	- Si bell: cortico, valacyclovir, pansement en verre de montre, vitA gel et larmes artificielles (éviter lésion cornées vu que oeil reste ouvert) - ENMG à 7j pour évaluer pronostic de récupération - Si Lyme: AB po sauf si sympt neuro autres que paralysie faciale → hosp et AB iv
2015	HSA		- Céphalée sentinelle avec diplopie transitoire - Céphalée en coup de tonnerre holo céphalique, irradie dans le cou et le dos - Méningisme: N/V, photophobie, raideur nuque - Fièvre - Parésie, aphasie, convulsion - Trauma?	Neuro complet: avec FO	- HSA sur trauma - HSA sur anévrisme - HSD - Hémorragie intracrânienne - AVC	- CT cérébral - Angio CT - Labo: Fss, électrolytes, VS, CRP, créat, crase	- Lit stricte - Analgésie - Hydrat - Réverser anticoag - Contrôle TA <160 - Bloqueur canaux calciques - Contrôle PIC: tête 30°, mannitol..... Clipping ou coiling
2015	Hernie cervicale			- Spürling - Lhermitte			
2016	Hydrocéphalie à pression normale	Trouble de la marche chez personne âgée : anamnèse sur une feuille. Réalisation uniquement du status	Pas d'anamnèse à faire	- Status neuro complet: - Orientation, 3 mots, dénommer, phrase, MONDE, action, répéter 3 mots - Méningisme - NC, force, sensi, réflexe, tonus, Babinski, doigt-nez,	- Masse? - Parkinson - AVC - B12 - Thyroïde	- Labo: B12, TSH - IRM - PL	PL

				marionnettes, marche, tremor			
2016	• Hernie discale	• Douleur lombaire sans signe déficitaire => probable hernie discale (DD : lumbago ?)	•	•	•	•	•
2016	• Névralgie du trijumeau	• cf cas 26 amboss	• Céphalées, suivies de sensations de brûlure • Caractériser douleur: localisation (facial unilat), durée (qq secondes), fréquence (100x/j), depuis quand, première fois, constant, intermittent, progression, facteurs aggravant/améliorant, trigger (mâcher, toucher), MA: N/V, photophobie, sudation, écoulement yeux, nez • Fièvre, convulsions, PC, trauma, vertiges, faiblesse, paresthésie, tr visuel, aphasie, infection récente (chercher sinusite)? • • Conséquences psy: dépression, suicides	• Neuro	• Si bilatéral: rechercher une SEP • • Migraine • Céphalée tension • Cluster headache (homme 20-40)	• IRM si perte sensitive ou bilatérale	• Carbamazépine • (Chir.) • • Sinon si cluster: O2, triptan • • Si migraine: triptan • • Référer au neurologue?
2016	• Céphalée + atteintes neuro focales	• Dame âgée probable métastases cérébrales du cancer du sein	• Caractériser céphalées • N/V, PC, photophobie, tr parole, tr vue, parésie, paresthésie, vertiges, trauma,... • Poids, appétit, fièvre, sudations nocturnes • Infos sur son cancer du sein, quand, ttt, évolution, suivi	• Neuro • Sein? • Pulm	•	• Labo • CT/IRM	• Hosp. ? • Tumor board?
2016	• Guillain Barré	• Jeune avec fourmillement et perte de force MI symétrique	• Caractériser la plainte -> commence aux MI (paresthésie puis parésie) • Douleurs dos + articulations • Douleur neuropathique • Sensibilité, force, céphalées, vertiges, trouble marche, ataxie, problème de vue, audition, dysphagie, dysarthrie (peut atteindre nn crâniens) • Atteinte autonome: Dyspnée, douleurs thoraciques, palpitations, sudations. Trouble urinaire et transit. • ⅓ cas: infection précède (GI ou tracte resp) -> C. jejuni, CMV	• Neuro : • Hyporéflexie, • Trouble sensibilité • Cardio aussi?	•	• PL (dissociation cyto-albumine: cellules normales, protéines élevés) • ENMG (ralentissement de la conduction nerveuse) • Sérologie C. jejuni • ECG (diminution de la variabilité de la FC ou arythmie)	• Hosp avec monitoring • (⅓ vont nécessiter ventilation) • IVIg haute dose • Evtl Plasmaphérèse • Prophylaxie thrombotique (HBPM) • • (PAS glucocorticoïde, marche pas, même si maladie AI)
2017	• AIT	• perte de force transitoire de la jambe unilat. Patient connu pour HTA et souffle carotidien au status	• Quand? durée, première fois? SA: tr vue (voile noir), aphasie, tr sensitifs, vertiges, céphalées, dysphagie, • Fièvre, frisson?	• Cardio: ausculter carotides!! • • Neuro complet	• AVC • Migraine avec aura • Epilepsie • Néoplasie •	• ECG • Angio-CT • • FSS, glycémie, crase, lipides, Na, K, créat • • Echo coeur et carotides	• Aspirine • • Hosp selon critères (> 60 ans, durée de l'épisode, HTA, diabète, épisode neuro récent...)
2017	• Canal lombaire étroit	• cf cas 3 USMLE	•	•	•	•	•

2017	• HSA/HSD?	• suite à chute chez vieux sous sintrom	• Cf plus haut	•	•	•	•
2017	• Migraine	• cas 26 amboss	• Caractériser la douleur : quand la douleur apparaît, où elle se trouve (holocrânien, sur les tempes, occipital), unilatéral/bilatéral, facteurs aggravants/soulageants, durée (dd de la céphalée de tension!), progression • Symptômes associés : prodrome avec aura, larmolement, paresthésies faciales, photo/phonophobie, N/V, ... • Drapeaux rouges : pire douleur, déclenché soudainement, fièvre, méningisme, convulsions	• Status neuro pour exclure toute cause urgente : nerfs crâniens, sensi, moteur ; penser à palper l'émergence du trijumeau; fond d'oeil ?	• Dx clinique! • En cas d'anomalie au status neuro, examen en fonction (IRM, CT, EEG)	• Migraine : • Céphalée de tension : • Cluster headaches : • Céphalée secondaire : • - infectieux : méningite, encéphalite • - vasculaire : HSA, thrombose veineuse, artérite temporale, AVC, crise hypertensive • - tumoral	• Limiter stimuli (lumière...) • • AINS • Triptan • • Anti-émétique

8. Urgences (hospitalières & en cabinet)

	Dg	Scénario ECOS	Anamnèse	Status	DD	Examen compl	PEC
2013	Dyspnée et Douleurs Thoraciques post chute	femme de 25 ans, chute à vélo il y a 3j, consulte pour douleurs latéro-thoracique gauche avec dyspnée. Status : hématomes + douleurs hypochondres gauches. => RX thorax/grille costal costal pour fractures de côtes (+ pneumothorax ?) et US abdo à la recherche d'une rupture splénique + donner antalgie ?					
2013	Vieille retrouvée au sol	- petite vieille amenée aux urgences en ambulance, car retrouvée par terre par son mari. A des vertiges en se levant. Sous amlodipine et ramipril. ECG : FC à 40, QRS large, sous décalage ST et T inversées.		- cardiaque - pulm - neuro vite fait	- BAV 3ème degré - NSTEMI	- ECG - trop, CK	- Pour BAV3 : - si stable : pacing externe - si instable (TA basse, DRS, OAP, glasgow abaissé), atropine ou isoprénaline et pacing externe
2014	Méningite?	- Céphalée et fièvre chez une jeune patiente => urgences avec infirmière à disposition	- caractériser la céphalée, EF, lésion cutanée, nausée, vomissement, phot phonophobie, écoulement lacrymal, - Trouble sensitif, troubles moteurs, convulsion, traumatisme - Contage - Atcd, voyage, vaccination, allergies, tabac, alcool, drogues	- Neuro complet, Glasgow, raideur de nuque, fond d'œil, meningisme: Kernig, Brudzinski - Sepsis : FC 130, TASys < 90, FR > 25, anurie, lactate > 4 sévère	- Encéphalite, masse tumorale,	- FSC, CRP, VS, lactate, Hb, bili, INR, plaquettes, gazo avec lactates - Hémocultures (2 paires) - Glucose - CT si besoin, PL	- SI sepsis : O2, fluides cristalloïdes iv, AB - Ceftriaxone 2g - Glucocorticoïdes iv
2014	Hypoglycémie	Obnubilation chez jeune homme. Infirmier à disposition					
2014	- Fx bassin - Cf cas RESCOS 2018 6e	- Traumatisme post AVP chez jeune : ABCDE : Fracture du bassin. Infirmier est à disposition.					
2015	Tachycardie supraventriculaire à réentrée?	femme jeune avec dyspnée aiguë					- valsalva, massage sinus, adénosine, diltiazem, électrophysiologie
2016	Palpitations (tb électrolytiques?)	-Jeune patiente avec sensation de palpitations résolues à l'arrivée aux urgences. (ECG à interpréter et prise de sang (Tb électrolytiques ?)	- Décrire palpitations - Depuis quand? Durée, première fois? SA: dyspnée, drs, sudations, angoisse, PC? - N/V, diarrhées? - Sympt thyroïde	Cardio pulm	- Tr rythme WPW? - Psy - Hypokaliémie (T plat)/hyperkaliémie (T pointue) - Anémie - Hyperthyroïdie	- ECG - Labo: FSS, Na, K, créat - gazo	- Selon cause: - insuline glucose - sodium bicarbonate - Hémodialyse - KCl
2016	Chute à vélo	Trauma thoracique et épaule suite à chute à vélo. Fx clavicule => prise en charge complète	- Chuté comment? quelle vitesse? quand? Casque? trauma crânien? PC? AC? Céphalées, tr visuel, dyspnée, toux,... - Dlr? → caractériser	- ABCDE? - Sinon cardio-pulm-abdo-épaule-clavicule - Vérifier qu'il n'y a pas	- Pneumothorax - Rupture rate - Contusion pulm - Fracture côtes	Rx	- Attelle 4-6sem (sauf si déplacé ou très raccourci ou si # latérale instable)

				de menace cutanée si # clavicule • Bien faire neuro-vasc			
2017	• Choc septique	• Pneumonie chez ancien tox	• Anamnèse rapide • • Si jms reprendre anamnèse quand patient stabilisé	• ABCDE • ou • • Cardio-pulm	•	• 2 paires d'hémocs • • Culture expecto • • Urine: antigène pneumocoque • Gazo, sat • Labo • Rx • HIV ? Virémie, taux CD4	• 2 voies • Remplissage • O2 • NA ou A • AB iv Tazobac
2017	• Choc anaphylactique	•	• Hétéro-anamnèse avec l'infirmier si présent	• ABCDE	• Crise d'asthme • Décompensation BPCO • Choc septique	• •	• Stade 1 + “: corticoïdes + antiH1 et adrénaline im en réserve si péjoration • Stade 2 + 3 :adrénaline, corticoïdes et anth1 • O2, remplissage • • Surveillance 4-6h voire plus si grave • RAD avec anti-H1, prednisolone 3j et EpiPen • RDV chez l'allergologue •
2017	• Dissection aortique	•	• Carct. douleur...	• TA des deux côtés! • Cardio-pulm • Abdo	• Pancréatite • EP • SCA • Rupture ulcère	• ECG • Angio CT	• Si Stanford A: chir immédiate • • Si Stanford B: conservateur sauf si complications (rupture, occlusion) • Morphine, contrôle HTA

9. Médecine interne

	Dg	Scénario ECOS	Anamnèse	Status	DD	Examen compl	PEC
2013	Insuffisance cardiaque	femme avec fatigue, arythmie, oedème prenant le godet, dyspnée	- dyspnée nouvelle ? progression ? facteur aggravant soulageant ? angor ? orthopnée ? dyspnée paroxystique nocturne? Prise de poids? oedème ? quand ? Nycturie ? fatigue ? FRCV tabac-OH - Voyage, néoplasie, op, varices, COC, ATCD de MTE, oedème, douleur, AF...	- CV (ne pas oublier reflux hépatojugulaire, oedèmes!, auscultation carotides) - Homans - Palpation mollets Pulmonaire	- EP - Insuffisance rénale - Insuffisance hépatique	- ECG - Gazométrie - SatO2% - FSS, BNP, pro-BNP - US cardio - Rx thorax (cardiomégalie, gros VG, congestion pulmonaire voir œdème pulmo)	- Hospitalisation si décompensation → O2, position assise, Morphine, Nitroglycérines, oedème poumon et pas d'hypotension, furosémide iv. - Si stable chgt habitudes de vie (diète pauvre en sel, réduction poids, restriction hydrique, diminuer OH et nicotine) - Médics: IECA, Bbloquant, Diurétique, evt antago aldostérone
2013	EP	Patient de 28 ans vient pour une dyspnée aiguë nouvelle	- Dyspnée depuis quand? Condition de survenue? Progression? Respiration superficielle ? augmentation de la FR ? Facteur aggravant/soulageant? premier épisode ? Douleur associée (poitrine/jambe)? Palpitation ? Syncope? toux ? Expectoration? Asthme? sifflement? - FRCV, FR TVP douleur de jambe? œdème? antécédents familiaux? OP récente ? Voyage ? Néoplasie ? Coagulopathie ? Grossesse ? œstrogène ? Varices ? - symptômes généraux? Antécédents maladie chirurgie médicament allergie? habitude de vie OH tabac drogue home?	- Status cardiovasculaire (aussi œdème des MI, signe de Homans) - Status pulmonaire	- Pneumothorax - Infarctus du myocarde - Pneumonie atypique - TVP/EP	- ECG - TA ddc - Gazométrie, SatO2, T° - FSS, D-dimère, crase - Créat, électrolytes, CK, Troponines - Angio-CT selon FR - US doppler des MI selon FR	- Hospitalisation - stabiliser le patient si instable (remplissage si hypotension) O2 selon satO2 - Héparine IV
2013	Psychosomatique? Le même cas qu'en psy? (cf plus haut)	Douleurs thoraciques et dyspnée persistante multi-investiguée => psychosomatique ?					
2013	Toux chez patient avec VAD	Ventricular assist device?					
2013	Artériopathie oblitérante des MI (AOMI)		Crampes, paresthésie, Douleurs: - Localisation, irradiation, qualité, intensité, depuis quand, constant/intermittent, progression, condition de survenue, première fois?, facteurs aggravant (pire avec exercice)/améliorant (repos), manif associées → claudication intermittente (combien de mètres?), pieds froids?, décoloration peau, changements trophiques (poils, température, ongles cassants, peau atrophique/fine, livedo reticularis, gangrène, ulcère, nécrose), - dysfonction érectile? - TABAC? autres FRCV	- CV complet : - Cardio Palpation/auscultation pouds, temps recoloration, température etc... - Sensibilité, Force, ROT - Romberg - Pallesthésie, sens postural etc...	- Vasculite - Thromboangéite oblitérante (Raynaud, thrombophlébite migratoire) - TVP - Claudication neurogène : - Canal lombaire étroit - Neuropathie diabétique - Polyneuropathie OH	ABI < 0.9 (Us doppler) (Labo ? B12, acide folique, thiamine, glucose, HbA1c, cholestérol) - Quantifier distance de marche sur tapis roulant	Stop tabac Exercice supervisé Modif FRCV : - ASA - Statines - Anti-hypertenseur - Sinon intervention chir : - Angioplastie +/- stent/pontage - Soins de plaie +/- greffe
2013	Déficience B12	Végétalienne. Anémie macrocytaire. Anamnèse et status gynéco dans la N					

2013	• Lupus???	• Fatigue chez jeune femme	• 11 critères (>4/11) : rash malaire, rash discoïdes, photosensibilité, ulcère buccaux, atteinte neuro (épilepsie, psychose), pancytopenie, pleurésie/péricardite, ANA, arthrite, anomalie hématologique, anomalie immunologique, atteinte rénale • Raynaud, nausées vomissement, syndrome sec, fatigue, fièvre, perte de poids • Atcd (épanchement pleuraux, péricardite), voyages, symptômes B, tabac, alcool, drogue	• Dépend de la plainte, mais tout	• Arthrite rhumatoïde • Sclérodermie • Dermatomyosite • Polyarthrite noueuse	• Facteurs immunologiques • Test de Coombs • Anémie, FSS, VS, CRP • Électrophorèse des protéines • Créatinine • Biopsie peau et rénale • Exposition à la lumière UV à lésions	• AINS • Anti-malarique • Crise : Glucocorticoïdes • Si sévère avec atteinte organes vitaux : • Glucocorticoïdes • Azathioprine/Méthotrexate
2014	• Asthme	• Toux chez homme jeune	• Toux, quand (+ le matin, nuit?) expectos, sang? dyspnée, douleur, reflux, contage, animaux, Tb, bruits pendant respiration? Infection récente, fièvre, symptômes B. • Rhinite allergique, eczéma, • Allergie, toux saisonnière? Profession? Voyages? • Exposition à animaux, poussière/moisissure	• Pulmonaire (pas oublier ongles, ganglions) • Evtl Cardio	• Pneumonie typique/atypique • Bronchite • GERD • BPCO	• FSC: paramètres inflammatoires, éosinophilie • Gazométrie • SatO2 • Spirométrie • Peak flow (et post-SABA) • Test de provocation à la métacholine • Evtl Rx thorax • Dx allergie : • Prick test • IgE totaux	• O2 • SABA (Ventolin) • Cortico iv • Adrénaline inhalation • Si échec : • B2 en IV attention répercussion hémodynamique • Chronique : • Éviter trigger • Ventolin au besoin • Budésonide • LABA (Salbutamol)
2014	• Bronchite/pneumonie	• Toux chez jeune patient	• Cf ci dessus	•	•	•	•
2014	• FA	• Palpitations femme de 60 ans	• -caractériser si c'est cœur qui bat vite ou impression que c'est irrégulier • -depuis quand? motif de survenue ? fréquence? Symptômes associés? • -FA : Palpitation, syncope, vertige, agitation, transpiration • -Anamnèse CV et Pulm (dyspnée, orthopnée, dyspnée paroxystique nocturne, œdème, nycturie, fatigue, angor, syncope, toux) • -symptômes hyperthyroïdie • -FRCV • -Anamnèse personnelle + familiale	• CV • Pulm • Thyroïde	• Flutter • Hyperthyroïdie • Électrolytes • Hypokaliémie	• FSS, TSH électrolytes • Crase • ECG • Holter • US cœur	• PEC : CHA2DS2VASC • 1. Anticoag • 2. Antiarythmique • 3. Contrôle fréquence B-bloquant • Cardioversion • Ablation par cat.
2014	• Sténose aortique • Symptômes :SAD (syncope,angor, dyspnea)	• Syncope chez patient âgé	• Syncope: prodrome, phase post critique, morsure de langue, perte des urines/ selles convulsions, TCC • Durée convulsions/PC • DRS, palpitation, dyspnée, faiblesse, fourmillement, trouble de la vue • Anamnèse CV NEURO • Antécédent	• CV • Ne pas oublier d'ausculter les carotides • NEURO	• vaso-vagale • orthostatique • hypoglycémie • épilepsie • intoxication • AVC •	• FSS, élytes • ECG • Rx thorax • US cardiaque	• Suivi si asymptomatique • Symptomatique : • TAVI • Chir
2014	• Insuffisance cardiaque	• Dyspnée	•	•	•	•	•
2015	• Poste double HTA	• a) Anamnèse + prévoir examen • b) lecture des résultats et expliquer au patient + suite du PEC	• Anamnèse générale tous les systèmes • Céphalées derrière la tête, vertiges, acouphène,	• CV • PULM • ABDO	•	• FSS, électrolytes, créat urée, dyslipidémie HDL LDL cholestérol total triglycéride glucose à jeun ou	• Revoir le patient expliquer les FRCV et complications • Mettre en place ttt selon résultats

			vision trouble, épistaxis, poulx bondissant - Anamnèse personnelle - Anamnèse familiale FRCV diabète tabac dyslipidémie HTA obésité sédentarité alimentation			HbA1c - Urines: microalbuminurie - TSH - ECG - HTA au cabinet + prendre à la maison sur 2 semaines (ou HTA sur 24h)	
2015	Polypes nasaux + asthme	Cf asthme plus haut					
2015	Poste double BPCO?	1) Dyspnée depuis 6 mois: anamn/status et complémentaire 2) décrire spirométrie + pseudo-motivationel sur tabac	- Depuis quand? - Constant/intermittent - Progression - Première fois? - Facteur aggravant/améliorant - MA: toux, fièvre, frisson, asthénie, poids, appétit, sudations nocturnes, DRS, OMI, orthopnée, DPN, nycturie, palpitation, syncope etc. - Sympt d'IVRS - Contage - Voyage, exposition à TB - TABAC!	- Cardio complet: reflux h-j! - Pulm complet - ADP cou	- Insuff cardiaque - Cancer poumon	- Rx thorax - Spirométrie: diminution CV, VEMS et VEMS/CV, augm VR - Non réversibilité - Courbe concave car augm résistance - ECG, US cœur - Gazo, Sat02.	Stop tabac - Vaccins pneumocoque, grippe - SABA - LABA - Cortico inhalé
2016	Leucémie?	Hémorragie gingivale, fatigue et ictère des sclères => probable leucémie/autre maladie hématologique : prise en charge complète.	- Fatigue, pâleur → anémie - Pétéchie, épistaxis, hématome → thrombocytopénie - Hépatosplénomégalie - Céphalées, tr visuels - Fièvre, poids, sudations nocturnes - ADP Pentade: fièvre, sympt. neuro (convulsions, déficit focaux, céphalées, vertiges...), thrombocytopénie (pétéchies, saignement muqueux...), anémie hémolytique (pâleur, fatigue, ictère), rénal (hématurie, protéinurie, oligurie, anurie)	- Conjonctives, peau - Ganglions - Abdo : HSM - Neuro?	Purpura thrombotique thrombocytopénique	- Labo: FSC, électrolytes, créat, VS, CRP, LDH, haptoglobine, bili, réti - Combs - Frottis sanguin - Ponction moelle - Stix urinaire? (hématurie, protéinurie)	Référer à l'hémato
2016	Insuff veineuse	Plaie tibiale qui ne guérit pas => ulcère sur insuffisance veineuse => prise en charge complète	- Lésion depuis quand, première fois? déjà entrepris un ttt?, douleur, écoulement, dlr nuit/effort, évolue, autres lésions, notion de trauma, claudication intermittente, paresthésie associée, prurit, dermite ocre, oedème, varices, - Métier (tout le temps assis ou debout), atcd de thrombose, ulcères, reynaud associé? - Dysfonction érectile si homme, anamnèse cardio IC, si femme grossesse, AF	- Cardio vasculaire (extrémités chaleur, rougeur, oedèmes, poulx) - ABI	- AOMI Mal perforant - Pyoderma gangrenosum	- FSS glucose à jeun, HbA1c, paramètres inflammatoires - ABI US doppler - Phlébographie	- COMPRESSION! Froid. Jambes élevées. Marche, drainage lymphatique etc - OP des varices
2016	Décompensation cardiaque post-op	Dyspnée chez patient âgé en post-op. PEC complète	Cf plus haut		- Pneumothorax - EP	- ECG - Labo: FSS, nt-proBNP - Gazo, sat - Rx thorax	- O2 - Nitré - VNI - Diurétique anse

2016	• Infarctus inférieur	• Douleur abdo chez une femme de 60 ans au cabinet => anamnèse, status et PEC => transférer pour infarctus inf !!!	• Douleur : localisation, irradiation, type, intensité, survenue, évolution, facteur aggravant/soulageant, facteur déclenchant, symptôme associé • Anamnèse CV, Abdo	• CV • Abdo	• Perforation gastrique	• FSS électrolytes, Créat • CK trop • ECG	• O2, morphine, nitroglycérine, aspirine, clopidogrel, • Tel 144 pour transfert ambulance voir filière STEMI avec SMUR si a les critères
2016	• Asthme	• Jeune homme avec toux	• Cf plus haut	•	•	•	•
2017	• Infarctus inf	• Sympt atypiques	•	•	•	•	•
2017	• Péricardite	• Jeune patiente 19 ans douleur à la poitrine depuis ce matin (invention)	• -Angor ? Localisation ? Irradiation? Caractère ? Mode de survenue ? Depuis quand? Evolution ? Facteur aggravant/soulageant? • -CV: Dyspnée, orthopnée, DPN, palpitations, syncope, oedèmes, nycturies, FRCV, infection récente • -anamnèse personnelle et familiale	• CV • PULM	• myocardite • angor stable angor instable • STEMI NSTEMI	• FSC, paramètres inflammatoires, CK, trop, électrolytes, créat, urée • hémoculture ECG - Rx thorax - US coeur	• -monitoring • -hospitalisation si patient instable → tamponade • -AINS • -repos • -contrôle à 24 et 48 h et 4s

10. ORL

	Dg	Scénario ECOS	Anamnèse	Status	DD	Examen compl	PEC
2013	Rhinite allergique	présente une rhinorrhée claire + éternuements depuis un mois. Même chose l'an passé à la même période. A déménagé depuis 2 ans à la campagne	- Même période - Campagne - Décrire la rhinite - Toux +facteurs aggravant/améliorant - Sympt associés: oculaires, gorge, peau, dyspnée • - Connu pour allergie? Famille?	- Muqueuses congestionnée • - Rhinoscopie ant: muqueuse nasale bleu pâle	- Rhinite médicamenteuses • - Rhinite vasomotrice • •	IgE spécifiques?	- Éviter l'allergène - Douche nasale à base d'eau de mer/salée + corticoïdes nasales (nasonex ou dymista) + antihistaminique. - Évtl tests allergiques. •
2013	Bouchon de cérumen	•	- Gêne dans l'oreille - Diminution soudaine de l'ouïe unilat • - Première fois??	- Otoscopie - Weber/Rinné	- Trauma acoustique • • •	Nichts	- Enlever par lavage à l'eau ou extraction manuelle (pince, curette, aspiration) • - Expliquer d'utiliser l'eau et non les cotons-tige
2014	Otite	Pas d'info si chez adulte ou enfant	- Dans 1 oreille ou les 2 - Otalgie, écoulement, prurit, - Fièvre, frissons - Ouïe diminue, acouphène, vertiges - Nez congestionné? Rhinorrhée, odynodysphagie, céphalées • - si externe: otorrhée + notion de baignade en piscine (Attention diabétique!!) • • •	Moyenne: tympan érythémateux, épaissi, fin ou bombé • Externe: CAE érythémateux, rétréci • - Pas oublier de regarder et palper mastoïde • - Examen ORL complet: avec ggl aussi, Rinné, Weber, audition	•	•	Moyenne: initialement décongestionnants nasaux et AINS (surtout pour OMA débutante) si inefficace au bout de 2j => AB amox • Externe: ciproxine HC en goutte - si diabétique => ciproxine p.os!!
2014	Névrite vestibulaire	•	- Vertiges qui durent des heures, indépendant de la position • - Nausées et vomissement, marche instable - Important de demander si boutons apparus (=zoster?) • - ATCD infection virale? • - Demander si perte audition, acouphène (ce qu'il n'y a pas) • - Trauma? Céphalées?	- Nystagmus battant du côté sain aboli à la fixation • - Halmagyi pathologique - Examen neuro (nerfs crâniens, force, sensibilité) - Chute du côté atteint • - Examen ORL - Rinné, Weber - Dix hallpike	- Zoster Oticus (= Ramsay Hunt=sous forme de la névrite vestibulaire) • - AVC • - Ménière (acouphène, perte audition) • - VPPB (chng position, pas de perte audition ni acouphène)	- Audiométrie dans la norme • - Calorique du côté atteint avec réponse diminuée	- Repos - Symptomatique: Antivertigineux, anti-émétique • Glucocort de courte durée • - Physio: réhab. vestibulaire
2014	Abscès pilier ant amygdales	•	- Fièvre, malaise, odyno-dysphagie, voix étouffée, bave, halitose, trismus - Contage	- ORL: Trismus - Uvula shift du côté controlat. - ADP cervicale	•	CT!!!! - Gram et culture - Labo: FSS, VS, CRP, électrolytes (si déshydraté pk il ne peut plus boire)	- Hosp + AB iv+ contacter ORL • - Irfen, Dafalgan pour douleur et EF • +/- incision, drainage

2016	• Otosclérose • Baisse de l'audition : Amboss 23 USMLE 17	• Baisse audition unilat chez jeune femme • (tout sauf ttt) • •	• Baisse audition unilat • • Acouphène • Pas d'otalgie • • Famille? (+- AD) • • Grossesse/hormones? (empire) • • Entends mieux quand y a du bruit autour! (Paracousis Willisii) • • Depuis quand? constant/intermittent, progression, facteur précipitant, Écoulement, douleur, vertiges, quels sons en particulier? Localiser le son? comprendre langage? Trauma acoustique? Métier avec du bruit?	• Otoscopie Normale • • Rinne/weber (surdit� de transmission) •	• OMA • Trauma	• Audiométrie	• Pas grand chose à faire à part adresser chez ORL! • • (Stapédectomie -> remplacer étrier par prothèse)
2017	• Vertiges	•	• Durée: très important, position dépendante? Acouphène + surdit�? 1 er épisode? • Chute? Nausées et vomissement?	• Examen neuro + ORL • • Si périphérique (=vestibulaire), nystagmus bat du côté sain (sauf pour VPPB) • • Halmagyi négatif, nystagmus typique d'atteinte centrale (augmente à la fixation, vertical, multidirectionnel) + skew deviation positif = sensibilité 100% pour atteinte centrale (=HINTS)	• Névrite vestibulaire (vertiges uniquement) • • Ménière (vertiges, surdit� basse fréquence +- acouphène) • • Schwannome (initialement atteinte acousie progressive et unilat puis vertiges progressif + acouphène). Si schwannome bilat => NF type II • • HypoTa orthostatique (déshydraté?)	• Audiométrie • Calorique • (Potentiel évoqués) • • IRM si suspicion schwannome acoustique (perte audition unilat, autre tr neuro (NC))	• Si central => URGENCES neuro • • Si Ménière: Betaseron (antivertigineux) + adresser chez ORL • Si Névrite vestibulaire: cf plus haut. • •

11. Urologie

	Dg	Scénario ECOS	Anamnèse	Status	DD	Examen compl	PEC
2013	Prostatisme?	- Homme 70 ans, difficulté à uriner, pas d'autres plaintes. Status : gêne suspubienne + TR a faire sur un mannequin. PEC : dosage PSA + US prostatique.	Difficultés initier miction, maintenir flux, jet faible, dribbling, urgence, nycturie, dysurie, pollakiurie, hématurie, fièvre, poids, asthénie, appétit, sudations nocturnes, dlr abdo, dlr dos	- Abdo - TR - Percuter loges rénales - Dos: percussion, palpation	- HBP - Carcinome prostate - Prostatite	- Stick urinaire - Labo - PSA - US prostate	- alpha bloqueur - chir
2014	Pyélonéphrite		- Caractériser la douleur, EF, symptômes urinaires irritatifs, douleur lombaires, nausées vomi, diarrhées, constipation, hématurie, caillot - Nombres d'épisodes dans le passé - Atcd (infection urinaire, lithiases, diabète,), tabac, alcool, drogue, voyage, symptômes B - Homme : hyperplasie prostate connue, jet faible - Femme : grossesse actuelle - Anamnèse sexuelle et gyn (pertes, prurit, saignement, dyspareunie)	- Abdominal : loges rénales, TR	- Infection urinaire simple, prostatite, lithiase, spondylodiscite	- Urines : stix, cultures (PCR chlamydia, gono) - FSS, CRP, créat - Test de grossesse - Hémocultures chez patient hospitalisé +/- US abdominal si : - Persistance des symptômes 48-72 heures après début AB - Pyélo compliquée - Suspicion de lithiase - Hématurie persistante - Diabète - Anted d'une opération uro-génitale - Immunosuppression - Pyélo récidivante - urosepsis	- Chez femme enceinte : Amoxi-clav p.os, céphalosporines 3 -ème génération. - Si compliquée : pip-tazo - Non compliquée : ciprofloxacine 500 mg 7jours - Critère d'hospitalisation : pyélo compliquée, comorbidité, patient âgé, femme enceinte
2014	Dysfonction érectile		- Minimum depuis 6 mois, depuis quand, continu/intermittent, progression. - Désir? Ejaculation? - Difficulté à initier, à maintenir - Erection matinale - Anamnèse sexuelle - Avec tous ses partenaires ou certaines? MST? - Médicaments!! (betabloquant!) - Anamnèse psychosocial - Dépression, anxiété - Céphalées, tr visuel, gynécomastie (tumeur pituitaire) - Neuro-vasculaire. - Claudication MI - Endocrino (diminution force, barbe pousse + lentement, perte cheveux), thyroïde - Trauma? - Intervention uro?	- CV → palper les poulx - Abdo: souffle? - Examen génital	- Etiologies: -vasculaire: HTA, DM, maladie CV, hyperlipid., tabac, AVC - Endocrino: Hypogonadisme, hyperprolactinémie - hypo/hyperthyroïdie - Medic: BB,SSRi, antipsychotique - Trauma uro - Psy	- Diagnostic clinique - Dosage des hormones: testo, prolactine, TSH, LH/FSH - HbA1c, lipides - Phallographie (mesure les érections nocturnes) - US doppler du pénis	- Traiter en fonction de la cause: - Stop tabac - Psychothérapie - inhibiteur phosphodiesterase 5 (sidénafil=viagra) - injection intracaverneuse - Testostérone - Pompe - Prothèse

2016	• Cancer vésical • • Cf cas 2 USMLE	• Hématurie macro + caillot de sang, patient âgé • (tout sauf ttt)	• Quantité, caillots? A quel moment de la miction? Première fois, combien de fois, depuis quand, progression, à constant/intermittent, dlr, dysurie, pollakiurie, difficulté à initier miction, jet faible, dribbling, sensation vessie pas vidée • Fièvre, frisson, poids, asthénie, appétit, sudations nocturnes • Trauma? • N/V, diarrhées, constipation • • Travail: attention si peintre par ex	• Abdo: TR • Uro: loges rénales • Examen génital	• Lithiase • Carcinome rénal • GN (Berger) • IU	• Stix urinaire, culture • Labo • Cystoscopie • • US rénal	• Référer
2017	• Prostatite	• IU basse chez l'homme d'âge moyen => ne pas oublier TR	• Dysurie, pollakiurie, urgence, hématurie, dlr loges rénales, fièvre, frissons? dlr périnéale, pire à la défécation • • Anamnèse sexuelle • Intervention uro récente? • Douleur à l'éjaculation • Sympt de HBP	• Abdo: TR!! • loges rénales	• Pyélonéphrite	• Stix, culture • Labo: FSC, VS, CRP, créat, électrolytes • • Frottis pour chlamydia, gono si risque	• Ciprofloxacine si risque IST faible • • Sinon ceftriaxone, doxy
2017	• Incontinence urinaire	•	• Médic à demander: diurétique, alphabloquant, anticholinergique, antidépresseurs, sédatif, antipsychotique, opiacé, anticalcique, antihistaminique, anti-parkinsonien • • Différencier incontinence de stress, urgence ou mixte • • Depuis quand? Constant/intermittent, progression? Dans quelles situations? (si toux, éternuements, sport) • Dysurie, pollakiurie, urgence, hématurie, difficultés à initier miction, jet faible... • Chercher hydrocéphalie à P normale: marche, démence • Constipation? • Voir impact sur le quotidien...	• Neuro, abdo	•	• Stix, créat, glucose, électrolytes • • Calendrier mictionnel • • US vésical, US prostatique • Cystoscopie, • Examen urodynamique	• Selon cause • • Protection • Pessaires • • Physio pelvienne • Anticholinergique • ttt infection

12. Endocrino

	Dg	Scénario ECOS	Anamnèse	Status	DD	Examen compl	PEC
2013	Hyperthyroïdisme	Femme 45 ans : fatigue, intolérance au chaud, thyroïde augmentée en taille, pas de changement au niveau du mode de vie. Status : thyroïde augmentée en taille. Hyperréflexie	- Depuis quand fatiguée? Progression - Ev. précipitant - Fièvre, frissons - Poids - Appétit - Sudations nocturnes - Questions thyroïde: cf à gauche, plus diarrhées, tremor, anxiété, palpitations, tr cycle - Sympt associés si sévère: dyspnée, stridor, dysphagie, voix rauque - Questions humeur	- Palpation thyroïde, auscultation souffles - Cardio-pulm - ROT - Force	- Dépression - Anxiété - Hyperthyroïdisme factice	- FSS, TSH, T3, T4 - US thyroïde - Scinti	- B-bloqueurs - Anti-thyroïde: méthimazole - Ablation iode radioactif - Chir
2015	Thyroïdite	déguisée en pharyngite	- Caractériser douleur - Depuis quand? Première fois? - Constant/intermittent - Progression - Aux solides, liquides - Rhinorrhée, toux, fièvre... - Contage - Infection récente? Sympt hyperthyroïdie: intol chaud, diarrhées, tremor, anxiété, perte poids, appétit, fatigue, oligo/aménorrhée Douleur en avalant, irradie dans machoires/oreilles, exacerbée par mouv nuque, toux, avaler - Puis sympt l'hypothyroïdisme	- Palpation thyroïde - Cardio-pulm - ORL	- De de Quervain - Thyroïdite subaiguë lymphocytaire - Pharyngite - Néoplasie?	- Labo: TSH, T3/T4, VS, CRP - US thyroïde +/- FNA - scinti	Phase thyrotoxique: Bbloqueur, AINS (cortico) Phase hypothy: - Levothyroxine faible doses
2017	Prolactinome	réduction du champs visuel depuis 6 mois sur prolactinome (commencer initialement par dopaminergique puis voir si chir nécessaire)	- Décrire quels champs visuels, vision trouble, double, flash, photophobie, mouches volantes, céphalées, gynécomastie, galactorrhée, aménorrhée, infertilité, atrophie vaginale/sécheresse, dysfonction érectile, baisse libido, N/V, convulsions - Fièvre, frisson, asthénie, perte poids, appétit, sudations nocturnes	- Examen ophtalmo - Examen neuro	- Méningiome - Autre tumeur	- IRM (CT) - Prolactine	- Bromocriptine - Chir.

13. Infectiologie & Immunologie

	Dg	Scénario ECOS	Anamnèse	Status	DD	Examen compl	PEC
2013	- Tuberculose - cf cas 31 Amboss	Jeune femme de 30 ans : fièvre et toux persistante depuis lgt (sudation nocturne aussi ?). Demander voyage, professions et tout le tralala => contagé +					
2013	Endocardite					Hemocs + TTE/TEE	
2014	GE ou intox alimentaire	Nausées/Vomissement chez femme de 30ans					
2014	Sarcoïdose	Érythème noueux, fièvre et arthralgies	- Caractérisation? Evolution? - Arthralgie: localisation, symétrie, migration, oedème, chaleur, rougeur, notion d'infection récente - Fièvre: T°, depuis, quand ondulante, persistante, fatigue perte de poids sudation nocturne - IBD: trouble du transit, diarrhée, sang - Toux ? Dyspnée - Dlr yeux/rougeur/photophobie→ uvéite	- CV PULM - Cutané - Ostéo-articulaire	- TB - Lymphome (Lupus, IBD)	- FSC paramètre inflammatoire - enzyme de conversion IgG calcium CD4/CD8 augmenté RX pulm - CT - Bronchoscopie + Biopsie	- PEC en ambulatoire ? Glucocorticoïde immunosuppresseur - AINS pour les sympt.
2015	- Grippe 25 ans		- Trucs de base: fièvre, céphalées, dlr muscles/articulations, toux sèche, ggl - contagé, vaccin Anamnèse sexuelle	- Cardio-pulm - ORL - Hépatosplénomégalie	Primo-infection VIH - Angine strepto	- Test VIH - Frottis strepto	- Hydratation - Dafalgan
2015	MST	- rentre de vacs - écoulement blanchâtre et brûlure urétrale					
2016	Diarrhée, sort de prison	- homme de 40 ans - cf cas 8 Amboss	- Fréquence, consistance, quantité, sang/mucus?, depuis quand? Trigger? constant/intermittent? Progression? MA: dlr abdo, fièvre, frisson, N/V, asthénie, perte poids, appétit, sudations nocturnes, alimentation - Rash (aphtes?), arthralgie, tr vision Contagé Voyage	Abdo: TR	- Gastro-entérite - Crohn - RCUH - APP - Colon irritable	- Labo: FSS, électrolytes, créat, VS, CRP, ASAT, ALAT - Culture selles?	Prévoir coloscopie?
2016	Mononucléose	Fille de 20 ans => fièvre et maux de gorge	- Où exactement, odyno dysphagie, depuis quand? constant/intermittent, progression, première fois? Facteurs aggravant/atténuant, MA: fièvre, frisson, asthénie, appétit, perte poids, sudations nocturne, N/V, dlr abdo, diarrhées, constipation, ADP? - Sport pratiqués - Contagé Anamnèse sexuelle	- Cardio-pulm - Abdo - ORL: ADP!! palper sinus	- Angine strepto - Primo-infection VIH	- Labo: FSC, électrolytes, créat, VS, CRP - LDH/Transmanisage augmen - Frottis strepto - Sérologie EBV Sérologie HIV	- Stop sport pour 3-4 semaines - ttt symptomatique
2017	Tbc	Ca revient!!!					

14. Chirurgie plastique & Main

	Dg	Scénario ECOS	Anamnèse	Status	DD	Examen compl	PEC
2014	• Tunnel carpien	•	•	•	•	•	•
2017	• Brûlure 2ème degré • • Moitié du visage, tout l'avant-bras circonférenciel, thorax et abdomen = 25% • • Cf répét. de chir plastique 2018	• Patient qui se présente aux urgences pour brûlures par retour de flamme • • A très mal • • Lui et ses accompagnants sont paniqués • • Quoi faire?	• Avant AA: Donner un anti-douleur, rassurer le patient et sa famille !! • → Dafalgan + AINS • → Tramal • → morphine, fenta • • Quand? Où (extérieur, intérieur)? • Localisation ? Circonférentielle? • Surface? Douleur ? Type de douleur ? Irradiation ? perte de sensibilité ? Mobilité ? Mécanisme de la brûlure (liquide chaud, objet chaud, électricité, produits chimiques)? • Facteur soulageant/aggravant? • Dyspnée? Dysphagie, tr oculaire? • Qu'est-ce qui a déjà été fait ou mis sur les brûlures? • Antécédent personnel ? ttt? • Vaccin tétanos???	• Inspection palpation Présence de bulle de vésicule ? taille de la lésion? temps de recoloration ? Tirer sur les poils ? (si s'arrache: 2e degré prof) • • Sensibilité • ORL • Ophthalmo! • Pulm • • Estimation de la surface (25% ici) et de la profondeur de la brûlure (2e degré)	• Pemphigoïde • Steven Johnson • Brûlure 1er degré ou 3ème degré • Photodermatose • •	• PEC pour ce cas clinique: hospitaliser en centre spécialisé, attention à la brûlure circulaire, évaluation ophtalmologique (atteinte face) et ORL pour savoir si besoin d'intubation (brûlure sphère ORL qui pourrait se rétracter) • • Suite: ttt chir, douche, escarotomie, débridement, greffe	• Référer centre brûlure si 2ème degré >10% 3ème degré >5%, atteinte circulaire, atteinte articulations face des mains des pieds et parties génitales • inhalation intoxication • Irriguer (eau froide) • Antalgie • compresse crème antiseptique sulfadiazine d'argent • Tétanos
2017	• Morsure de chien	• Morsure au poignet avec atteinte ulnaire	• Quand? Où, évaluer risque de rage... • Animal connu, vacciné? • Situation dans laquelle il a été mordu: provocation ou comportement inhabituel du chien • Douleur, paresthésie, main froide, rougeur, chaleur, oedème, hématome, fièvre • Quand est-ce qu'il a mangé? (Si op à prévoir) • Vaccins?	• Inspection • Palpation (pouls...) • Mouvement passif/actif • Force, sens	•	• Labo • Frottis plaie si signes d'infection	• Urgence médico-chir! • Exploration chir sous AG avec drainage, rinçage etc. selon la morsure • Tétanos (si rappel > 5 ans) si plaie sale sinon 10 • AB iv co amox puis po • Vaccin rage + Ig • Si animal inconnu, ayant fugué → PEP • Si animal provient d'une zone terrestre probable: PEP + observer animal → stop si bonne santé à 10j • Si animal zone terrestre improbable, surveiller animal et PEP si animal dev. sympt • Annonce de la morsure au service cantonal compétent

15. Chirurgie viscérale & Gastroentérologie

	Dg	Scénario ECOS	Anamnèse	Status	DD	Examen compl	PEC
2013	Diverticulite aiguë	Douleurs en FIG chez vieille dame. CRP et Leuco augmentés + TR dans la norme. => Diverticulite. Donc CT dans l'immédiat et colonoscopie (une fois la crise passée ? - 6 semaines).	- Douleur quadrant inférieur G - Constip/diarrhée, changement - Petit EF - Nausées/vomi - Sang dans selles - Diète - Obésité - Tabac		- MICI - Cancer colorectal	- Baisse de Hb si saignement - CT avec contraste iv et oral (inflammation graisse péricolique) - Colono à faire lorsque la crise sera passée (risque de perforation en aigu)	- A jeun - AB oral (iv si complications ou N/V/tr transit) - Chirurgie si complications
2013	Pancréatite biliaire		- lithiase biliaire - Alcool - Chirurgie récente Douleur en ceinture typique, irradiant au dos, pire après les repas et couché, amélioré si se penche en avant. - N/V - Ictère	- Dlr épigastrique, distension, ileus → baisse des bruits abdo - Examen de la peau → ictère, signe de Cullen...		- Labo: FSS, urée, CRP, créat, ALAT, ASAT, PA, bili, Ca, TG, amylase, lipase Lipases augmentée 3x! - US (CT rarement utilisé) - ERCP	Hosp. - Fluides (cristalloïdes), analgésie - Bowel rest - ERCP + cholecystectomie
2014	- Soit cholédocholithiasie soit cholécystite - cf cas 1 Amboss	Douleur abdo	- Female, fat, fertile, fair, family history, forty - Douleur post-prandiale - EF, N/V - Voyage Ictère, prurit - Urines foncées, selles claires	Murphy (cholecystite)		Choléolithiasie: US Cholécystite: US, leuco, CRP, phosphatase alcaline, GGT, ASAT ALAT, bili, amylase, lipase	Choléolithiasie: Conservateur: analgésie, diète pauvre en graisse, spasmolytique ou ERCP ou cholécystectomie élective Cholécystite: Cholécyctectomie
2014	Ulcère gastrique						
2015	Ileus/cancer du côlon	Faire la totale					
2015	RGO	toux quand couché, brûlures	- exclure cause cardiaque dysphagie? odynophagie? N/V, hématurémèse, méléna - poids,... stress? - tabac? - sinon questions AS: fièvre, appétit, toux grasse? drs, palpitation....		- cardiaque - ulcère - néoplasie	- OGD si sympt alarme (perte poids, >50 ans, dysphagie, sang, anémie...) - ECG	- IPP - contrôle à 2 semaines
2015	Ileus chez patiente polycancéreuse	Dire qu'elle va en soins pall, qu'elle va mourir => annonce de mauvaise nouvelle.					
2015	Perforation ulcère gastrique	Faire la totale					

2015	Bilan pré-anesthésie cure de hernie inguinale	- Anamnèse, status et examen complet: - angor stable, dyspnée, souffle de sténose aortique) SAD: syncope, angor, dyspnée	- Soit par laparoscopie (sous AG masque laryngé), soit par voie antérieure (Anesth régionale ou locorégionale) - Compl post-op: récurrence, infection, douleur Anamnèse par système: drs, syncope, vertiges, angor, dyspnée, palpitation, Fièvre, orthopnée, OMI, nycturie, DPN, toux, ... - FRCV - Demander s'il a un pb dentaire, dents qui bougent, appareil, piercing, choses métalliques. Eval. Risque saignement : saignement important après op ? Hématurie inexpliquée, saignements gingivaux ? - Hématome/pétéchies inexpliqués Activités physiques possibles : faible, modérée, intense Médics à arrêter: AVK 3-4j avant avec relai HBPM, metformine 2j avant	- Cardio complet: ausculter les carotides! Les pouls (poul faible, retardé) - Pulm complet - Abdo - ORL?		- ECG - Labo : FSC, crase, glucose, créat US cardiaque - Rx thorax?	- Si asympt: ttt conservateur - Si sympt ou sténose sévère: chir ou TAVI
2016	Épigastralgies	femme de 68 ans					
2016	- Douleurs épigastrique + méléna - Cf cas 35 amboss	- Attention ne pas oublier le DD de infarctus inf. - Patiente diabétique	- Caractériser dlr - Première fois ? - Constant/intermittent, progression, durée, DRS, palpitation, OMI, sudation, vertiges, syncope, dyspnée... reflux, dysphagie, odynophagie, N/V, sang dans les selles...	- Cardio-pulm - Abdo	- Ulcère - Infarctus inf	- ECG - Labo: FSS, électrolytes, Trop - OGD car méléna	IPP
2016	Colite à C. Difficile	Diarrhée chez patiente en EMS, post prise d'ATB	- Depuis quand? Consistance (comme de l'eau), fréquence, quantité, sang/mucus dans les selles, fièvre, N/V, dlr abdo, appétit Signes de déshydratation - Voyage (on sait jms ahah) - Contage - Alimentation? - TTT AB? lequel, quand	Abdo: TR	- Gastro-entérite virale/bactérienne	- Toxine C difficile dans les selles - Labo: FSS, électrolytes, créat, lactate (Rx abdo)	- Stop l'AB - Hydrat - AB (vanco ou métronidazole) - Mesures d'hygiène et isolation!!!
2017	- RCUH ? - cf cas 8 Amboss	Femme jeune, diarrhées sanglantes 3 mois/an					
2017	Pancréatite		Douleur ? Caractérisation. Reflux, N/V, trouble du transit diarrhée, sang, ictère, dysphagie, brûlures gastriques,	- ABDO - CV - POULS, TENSION DDC	- dissection de l'aorte - perforation gastrique - gastrite	FSS, électrolytes, syndrome inflammatoire, tests hépatiques, amylase,	- Hospitalisation, antalgie, hydratation, nihil per os, alimentation progressive quand plus de douleur - ERCP si calcul

			symptômes urinaires, fièvre - Anamnèse CV - Antécédent - Calculs ? OH?			lipase - US abdo - US des voies biliaires - CT à 72h	
2017	Gastrite/Esophagite	- Épigastralgies - TTT d'épreuve aux IPP	Perte de poids ?				

16. Gynécologie

	Dg	Scénario ECOS	Anamnèse	Status	DD	Examen compl	PEC
2013	Grossesse +	femme de 38 ans : premier test de grossesse de sa vie positif. Donner les conseils de mode de vie et les dgts prénatales. Pas d'examen clinique.	DDR - Ménarche - Menstruations: régulières, douleurs, quantité, longueur - Contraception - RS - ATCD FC, avortement, grossesses - ATCD de MST Sympt grossesses: N/V, seins, poids, fatigue Sympt urinaires		- Grossesse normale - Grossesse ectopique - Grossesse molaire	- Répéter bHCG - US pelvien - examen gyn Groupe - Labo: FSS, ferritine, TSH, Groupe sanguin RPR, rubéole, HIV, Hbs Ag - PAP - Frottis gono, chlamydia - Stix urinaire, culture	Prévoir prochain rdv Info sur diag prénatal Conseils: laver, éplucher fruits/légumes, pas de viande crue, sushis, charcuterie, fromage frais - Limiter cafès - Eviter jardin, caisse chats - Stop OH, tabac, drogues Acide folique
2013	Prééclampsie (HTA + protéinurie)	femme 30 ans à 28 SA adressée par son gynécologue pour HTA et protéinurie (invention)	- Œdème? Poids? Dyspnée? Céphalée? N/V? Prob visuels? Acouphène? Douleur abdominale en barre? Convulsions (crises d'épilepsie)? Oligurie (diminution de la diurèse)? sensibilité à la lumière et au bruit? - Mvts fœtaux - Contractions? perte des eaux? sang? - FR: obésité, diabète, 1ère grossesse, jumeaux Anamnèse gyn: G.. P... Terme prévu, DDR,	- Neuro sensibilité grossière, réflexe (hyperréflexie) - Vision - Pulmonaire(risque d'œdème pulmonaire) - Abdo	Éclampsie HELLP	- TA urine : prot sang: créat urée électrolytes FSS ASAT ALAT GGT PA bili crase groupe - hémolyse :bili indirecte LDH haptoglobine GR - pour le bébé: US, US doppler, CTG (= test réactivité foetale)	- hospitalisation monitorer la mère et le fœtus - diminution de la tension (methyldopa) - sulfate de magnésium (prévention des convulsions) - éventuellement cortico pour maturation pulmonaire diurétique si œdème pulmonaire accouchement si HELLP ou éclampsie
2014	Infertilité chez femme		Anamnèse des 2 partenaires (enfants d'autres avec autre partenaire...) Anamnèse gynéco: DDR, régulier, quantité, durée, ménarche, pertes?, prurit, sécheresse, G..P..., FC, avortement, atcd de MST, RS depuis quand? quelle fréquence, nbr de partenaire la dernière année, dyspareunie? - Intol froid, cheveux sec, œdème, chgm voix, constipation... Tr visuel (diplopie, hémianopsie...), céphalées, galactorrhée - Hirsutisme, acnée, acanthosis nigricans - Règles abondantes, dyspareunie, dlr à la défécation	- Abdo - Peau: hirsutisme, acnée - Thyroïde - Gynéco	- Insuff ovarienne - Séquelles post PID - Dysfonction sexuelle: dyspareunie - Anomalie utérine: bicorne, léiomyome - Anomalie cervicale - Ac contre sperme - Hypogonadisme hypogondo - PCOS - Adénome pituitaire (prolactine) - Tr thyroïde - Infection chlamydia - Endométriose	- Prolactine - TSH - FSH	- Dépend de la cause... - Bromocriptine - Levothyroxine - Induction ovulation - Don ovocyte - FIV - Chir si adhésions utérines
2014	GEU	- douleurs abdo + aménorrhée - Cf cas 3 Amboss	- Retard de règle (date des dernières règles, histoire, ménarche, abondance, etc) spotting, douleurs abdo? - Nausées, vomissements, seins sensibles, élargis? - Pertes?, prurit, Anamnèse gynéco, sexuelle	- Status abdo - Status gynéco (spec, toucher vaginal, TR)	- Grossesse - Kyste ovarien, rupture de kyste - PID - Appendicite - Endométriose	- FSS, Na, K, créat... - Beta HCG sérum et urine - US - transvaginal (utérus vide, liquide dans cul de	Méthotrexate contrôle (diminution Beta HCG), refaire US endovaginal Anti D si Rh- - Laparoscopie si patiente hémodynamiquement instable /échec de ttt conservatif / FR rupture

						sac de Douglas,...) • Groupe	trompe
2015	• Cancer du sein	• anamnèse status et PEC	• Si nodule depuis quand ? douleur ? Rougeur, chaleur, fièvre, évolution ? écoulement du mamelon ? variation du nodule avec les règles. Anamnèse gyneco : Ménarche/ménopause, DDR, cycle, hx obstétrique, contraception, contrôle mammo • FR: ménarche tôt, ménopause tard, adiposité, contraception, ttt hormonal pdt la ménopause , DM type 2 irradiation du thorax, anamnèse familiale	• Examen des seins • Pas oublier ggl	• Adénome • Kyste • Lipome • Absès • Mastite	• Mammographie • US si <30 ans • IRM • selon lésion biopsie • +/- testing BRCA1 BRCA2 •	• imagerie biopsie PEC selon résultat
2015	• Femme 19 ans veut la pilule	• - Les souhaits de la patiente, en a-t-elle réfléchi, qu'est-ce qu'elle en sait, ses aprioris, culturel • - Anamnèse gyn: DDR, ménarche, règles régulières/quantité, dyspareunie, pertes (couleur, odeur, quantité), prurit? désir de grossesse, ATCD de grossesse/FC/avortement, vaccins (HPV) • - Anamnèse sexuelle: en couple, RS? fréquence, contraception actuelle? Prise de risque? Test VIH ou MST? Nbr partenaire actuel et dans la dernière année • - ATCD personnels : risque TVP, OH, tabac, drogues, diabète, HTA, surpoids, trouble de la coagulation, migraine, TVP • - ATCD familial : familial cancer sein/ovaire, trouble de la coagulation, AVC, TVP • - BMI • - Climat de confiance, entretien seul • - Toujours faire un test de grossesse • - CI : TVP, EP, AIT, AVC, cancer du sein dans la famille • - Présenter tous les moyens de contraception : • Pilule E-P : ne pas oublier, si oublié se protéger durant 7 jours (- tous les jours/risque TE/prise poids, + peut sauter les règles/règles régulières) • Pilule P: si risque thrombo-embolique (-tous les jours/règles irrégulières/prise poids) • Patch E-P: chgm toutes les semaines (- vérifier qu'il est tj bien collé/risque TE/prise poids , + règles régulières, peut sauter les règles) • Implant : dure 2-3 ans • DIU : 3-5 ans, avec hormones, plus efficace car pas de trouble de la compliance (- spotting, dlr, prix (400.-) +si intol E, long terme) • Cuivre : sans hormones (- spotting/hyperménorrhée, +long terme/sans hormone) • Anneau vaginal E-P : tous les mois (-sensation de gêne vaginale/risque TE/prise poids/infl vaginale, +cycle régulier/peut sauter les règles) • Injection: tous les 3 mois, contraception pas pour le long terme • Préservatif : (-manip nécessaire avant RS/effet sur sensation, +protège contre MST) • Diaphragme: (-pas facile à mettre/infl vaginale, +sans hormones) • • Oestroprogestatif : Thromboses, prise de poids, acnée, cholestase, trouble de l'humeur, céphalées, trouble du sommeil, sécheresse vaginale • Progestatif : pas de risque de TVP, perte de cheveux, baisse de la libido, sécheresse vaginale, aménorrhée fréquente, trouble de l'humeur, céphalées. • Petit labo, test de grossesse • • Demander si elle veut doc écrit • Dans les 2 : reprendre si vomissements/diarrhées • - Laisser un temps de réflexion • - Toujours dire que seul le préservatif protège contre les MST • - RDV de contrôle à 3 mois si introduction d'une contraception: poids, lipides • Reconsulter pour tout événement inhabituel après introduction nouveau moyen contraception.					
2015	• PID	• Dlr FID • s/p appendicectomie • tout faire avec examen complémentaire immédiat	• Caract. douleur... • Constant/intermittent • Progression • Première fois? • Sympt associé: N/V, fièvre, appétit, diarrhée, constipation • Symp urinaires • Voyage • Contage • Anamnèse gyn: DDR, ménarche, règles (régulières, quantité, fréquence, durée), pertes (couleur, odeur, quantité, sang?), prurit, sécheresse, G...P..., FC,	• Abdo: • Gynéco: douleur à la mobilisation du col	• GEU • Rupture kyste ovarien • Torsion de kyste •	• Labo: FSS, électrolyte, créati, VS, CRP • US • Frottis • Test VIH • TG!!! • Stix urinaire	• Ambu: co-amox + doxy po +/- ceftriaxone im • Contrôle à 72h • • Hosp si: F>38°, N/V, grossesse, abcès tubo-ovarien • Co-amox + doxy iv +/- ceftriaxone im

			avortement • Anamnèse sexuelle: en couple, RS non protégés, combien de partenaires dans la dernière année, atcd MST, dyspareunie				
2016	• IU chez femme enceinte 14 SA	• pollakiurie	• Dysurie, pollakiurie, dlr loges rénales, sang, fièvre, frissons, pertes (couleur, odeur, quantité), prurit, sécheresse • Première fois? Depuis quand, progression • • (Mouv. bébé) • Perte sang, liquide • (Contractions) • Terme prévu, ... SA actuel, G...P...	• Abdo • Uro: loges rénales • Gynéco	• IU haute vs basse • • Urétrite • Vulvo-vaginite • Diabète?	• Stix, culture • Labo	• Si basse: co-amox po • • Si haute: hosp? Ceftriaxone iv
2016	• ??? • • Cf cas 4 Amboss	• Saignement vaginal +++ chez une femme de 46 ans : anamnèse, status avec vagin en plastique, PEC	• Début ? Quantité ? Caillots? Type ? Constant/intermittent? Progression? Première fois? Couleur ? Autre écoulement ? Trauma bassin?? Fièvre ? Douleur ? Prurit? Sécheresse ? Pertes: odeur couleur quantité? • Âge menarche? Fréquence ? quantité (nb de tampons/j) ? Dernière règle ? Ménopause ? Symptômes de ménopause? Hx obstétrique ? G...P... FC, avortement, Sexualité ? Rapport H/F ? douleur pdt les rapports ? saignements pdt/après les rapports ? • Contraception ? Dernier contrôle ? Dernier PAP ? Hx de MST ? Infection HPV? • Symptômes B • Symptômes urinaires/ transit •	• Abdo • SPEC • palpation bi-manuelle • •	• GEU? • • PID • • Infection vaginale • • Polype utérin/cervical • • Fibrome utérin • • Kyste de l'ovaire • • Cancer du col /Endomètre • ttt hormonal	• FSS, syndrome inflammatoire, crase • • Groupe • • Test de grossesse • • SPEC + frottis • • US endovaginal • • Biopsie de l'endomètre • IRM • • Pap smear •	• Stabilisation hémodynamique • • Si saignement aigu utérin: haute dose d'oestrogène conjugué ou acide tranexamique • • revoir la patiente pour colposcopie biopsie de l'endomètre +/- IRM
2017	• Prééclampsie cf plus haut	• Lire lettre gynéco avant d'entrer • céphalée + enceintes	•	•	•	•	•

17. Ophtalmologie

	Dg	Scénario ECOS	Anamnèse	Status	DD	Examen compl	PEC
2013	• Glaucome à angle fermé? Uvéite?	• Vieux de 65 ans, vient pour œil rouge douloureux depuis la veille avec irradiation douleur sur territoire V1 homolat. Status : mydriase areactive et opacification cornée d'après la photo. => Glaucome a angle fermé? Uvéite ?	• Caractériser douleur, écoulement purulent, autres, prurit, lésions cutanées associées (vésicules,rash), diminution AV, diplopie, images déformées, mouches volantes, flash lumineux, rideau noir, ptose, photophobie, epiphora, champs visuels diminués, porteurs de lentilles? Contage? Corps étrangers? Infections récentes? Checker neuro! Céphalées surtout. FRCV	• Ophtalmo Neuro	• Glaucome Uvéite	• Fond d'oeil • Gonioscopie • Tonométrie • Lampe à fente • FSS, paramètres inflammatoires	• Glaucome aigu: URGENCE! Faire diminuer la P (Mannitol iv, acetazolamide iv, bbloquant, adrenaline topique) Ne jamais induire de mydriase!! - Uvéite: ttt pathologie sous jacente, corticos, mydriatique (ATTENTION pas si glaucome à angle fermé)
2014	• Cataracte	• trouble vision chez patiente de 70 ans	•	•	•	•	•
2014	• Glaucome/uveite	• Douleurs oculaires	•	•	•	•	•
2015	• Kératite du soudeur	• Douleurs oeil, baisse vision • sculpteur de métal	• Douleur dans l'oeil, caractériser dlr: localisation, intensité, évol, qualité, irradiation, sympt associés (visions floue, double, photophobie, mouches volantes, flash, prurit, écoulement, rougeur, sensation CE), fact. aggravant/améliorant, chronologie, constant/intermittent, progression • 1 oeil ou les deux • Champs visuels atteintes • Premières fois? • • → associé à conjonctivite • • Travail? Protection? •	• Ophtalmo complet • • Neuro: NC	• Glaucome • CE • Uvéite	• Examen fluoresceïne	• Référer à l'ophtalmo • • Collyre anesthésiant • Compresse froide et humide
2016	• Déchirure de la rétine	• Patiente de 50 ans : tb visuel unilat depuis 2 jours. Anamnèse, status et mannequin pour le fond d'œil avec un chiffre a transmettre a haute voix. => Déchirure de la rétine => Référer ++ aux urgences ophtalmique.	• Depuis quand? Soudain? Progression, 1 oeil, les 2? Quels champs touchés? Première fois? Flash lumière? mouches volantes? photophobie? diplopie, vision trouble? rougeur, écoulement, CE? trauma? douleur (non douloureux) • • Douleur cuir chevelu, mâchoire, céphalées temporales	• Ophtalmo complet • •	• Horton	• Examen lampe fente • • Labo? VS	• Référer à l'ophtalmo
2017	• DMLA vs Récidive cataracte	• s/p OP cataracte binoculaire	• Vision trouble/double, quelles champs visuels, flash, mouches volantes, scotome, dlr, oeil rouge, écoulement etc.	• Ophtalmo:	•	•	• Référer à l'ophtalmo